



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PENDEKATAN PALIATIF DAN NUTRISI DALAM PERAWATAN KANKER

Nunung Nursasih
Nur Fithriyanti Imamah
Christina Yeni Kustanti

Editor: Lia Fadlilah



BUNGA RAMPAI: PENDEKATAN PALIATIF DAN NUTRISI DALAM PERAWATAN KANKER

Penulis:

Ns. Nunung Nursasih, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Ns. Nur Fithriyanti Imamah, MBA., Ph.D.

Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D.

Editor:

Lia Fadlilah, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Pendekatan Paliatif dan Nutrisi dalam Perawatan Kanker

Penulis: Ns. Nunung Nursasih, M.Kep., Sp.Kep.MB.
Ns. Nur Fithriyanti Imamah, MBA., Ph.D.
Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D.

Editor: Lia Fadlilah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-61-9

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "Bunga Rampai: Pendekatan Paliatif dan Nutrisi dalam Perawatan Kanker," dapat tersusun dan hadir di tengah para pembaca.

Kanker merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan, bukan hanya karena kompleksitas penyakitnya, tetapi juga karena dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup pasien dan keluarganya. Dalam menghadapi tantangan ini, peran tenaga kesehatan — khususnya perawat — menjadi sangat vital. Buku ini mencoba memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran keperawatan dalam mendukung pasien kanker, dengan fokus khusus pada pendekatan paliatif dan edukasi nutrisi, yang keduanya sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup pasien.

Buku ini disusun dalam tiga subtopik utama.

Pada bagian pertama, "Definisi dan Prinsip Keperawatan Onkologi," pembaca diajak memahami dasar-dasar keperawatan onkologi, meliputi konsep, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip yang menjadi fondasi dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik dan humanis kepada pasien kanker.

Bagian kedua, "Peran Perawat dalam Edukasi Nutrisi untuk Pasien Kanker," mengulas pentingnya asupan gizi yang adekuat dalam perjalanan penyakit kanker serta bagaimana perawat

dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan dukungan nutrisi kepada pasien dan keluarganya.

Sedangkan pada bagian ketiga, "Perawatan Paliatif pada Pasien Kanker," dibahas pendekatan paliatif yang berfokus pada upaya meningkatkan kenyamanan, mengelola gejala, serta mendukung kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial pasien di sepanjang perjalanan penyakitnya.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi para praktisi kesehatan, pendidik, mahasiswa keperawatan, serta siapa pun yang peduli terhadap peningkatan kualitas hidup pasien kanker. Semoga buku ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menumbuhkan empati dan komitmen untuk memberikan pelayanan keperawatan yang lebih baik dan bermakna. April, 2025

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 DEFINISI DAN PRINSIP KEPERAWATAN ONKOLOGI 1

Ns. Nunung Nursasih, M.Kep., Sp.Kep.MB.	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Definisi	3
C. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Paliatif.....	6
D. Indikasi.....	7
E. Lima kelompok besar yang digunakan untuk mengklasifikasikan kanker yaitu karsinoma, sarkoma, limfoma, adenoma dan leukemia (National Cancer Institute, 2009).	8
F. Prinsip Keperawatan.....	8
G. Pelayanan Paliatif meliputi kegiatan:.....	13
H. Kesimpulan.....	24
I. Referensi.....	25

CHAPTER 2 PERAN PERAWAT DALAM EDUKASI NUTRISI UNTUK PASIEN KANKER..... 29

Ns. Nur Fithriyanti Imamah, MBA., Ph.D.....	29
A. Pendahuluan/Prolog.....	29
B. Masalah Nutrisi Pasien Kanker	31
C. Peran Perawat	36
D. Peran Perawat dalam Edukasi Nutrisi Pasien Kanker	42

E. Simpulan	47
F. Referensi.....	48
G. Glosarium.....	53

CHAPTER 3 PERAWATAN PALIATIF PADA PASIEN KANKER..... 55

Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D.
..... 55

A. Pendahuluan.....	55
B. Area Perawatan Paliatif.....	58
C. Perawatan Paliatif untuk Orang dengan Kanker.....	64
D. Simpulan	78
E. Referensi.....	79
F. Glosarium.....	81

PROFIL PENULIS 83

CHAPTER 1

DEFINISI DAN PRINSIP KEPERAWATAN ONKOLOGI

Ns. Nunung Nursasih, M.Kep., Sp.Kep.MB.

A. Pendahuluan/Prolog

Kanker adalah sekelompok besar penyakit yang dapat mengenai hampir semua organ atau jaringan tubuh ketika sel-sel abnormal tumbuh tak terkendali, melampaui batas normalnya untuk menyerang bagian tubuh yang berdekatan dan/atau menyebar ke organ lain. Proses terakhir ini disebut metastasis dan merupakan penyebab utama kematian akibat kanker. Neoplasma dan tumor ganas adalah sebutan umum lain untuk kanker.

Kanker adalah penyebab kematian kedua secara global, yang diperkirakan menyebabkan 9,6 juta kematian, atau 1 dari 6 kematian, pada tahun 2018. Kanker paru-paru, prostat, kolorektal, lambung, dan hati adalah jenis kanker yang paling umum pada pria, sedangkan kanker payudara, kolorektal, paru-paru, serviks, dan tiroid adalah yang paling umum di kalangan wanita. (WHO)

Secara global Kasus kanker terus bertambah memberikan tekanan fisik, emosional, dan finansial yang luar biasa pada individu, keluarga, masyarakat, dan sistem kesehatan. Banyak sistem kesehatan di negara-negara

berpenghasilan rendah dan menengah yang tidak siap untuk mengelola beban ini, dan sejumlah besar pasien kanker di seluruh dunia tidak memiliki akses ke diagnosis dan pengobatan berkualitas secara tepat waktu.

Pada tahun 2020, hampir 10 juta kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit kanker, dengan 19,3 juta kasus baru (Zhang et al., 2022). Data Riskesdas 2019 menunjukkan bahwa jumlah penyakit kanker di Indonesia pada tahun 2013 meningkat dari 1,4 per 1.000 penduduk menjadi 1,79 per 1.000 penduduk pada 2018. Laporan Global Burden of Cancer Study (Globocan) dari World Health Organization (WHO) mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 396.914 kasus kanker di Indonesia, dengan 234.511 kematian yang disebabkan penyakit kanker. (Handayani, 2022).

Kanker terjadi semula ketika adanya sel-sel normal yang mengalami

kerusakan pada materi genetiknya (DNA). Sehingga sel-sel dalam tubuh tersebut berkembang dengan tidak terkendali. Kerusakan pada DNA bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetika, radiasi, polusi, lingkungan, infeksi, atau virus. Ketika DNA rusak, sel dapat berubah menjadi abnormal dan mulai membelah tanpa batas. Sel-sel abnormal ini akan membentuk massa yang disebut tumor. Adapun tumor yang bisa bersifat jinak, yang mana tumor jinak tidak akan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dan juga tumor juga bisa bersifat ganas, yang mana memiliki kemampuan untuk menyebar ke organ dan jaringan lain. Sel-

sel kanker akan menyebar dengan menembus jaringan di sekitarnya dan berpindah melalui aliran darah atau sistem limfatik ke bagian tubuh lain. Jika sel-sel kanker itu telah menyebar, dapat menyebabkan tumor di organ lain juga atau menjalar ke seluruh tubuh, sehingga kanker dapat berkembang menjadi stadium lanjut.

B. Definisi

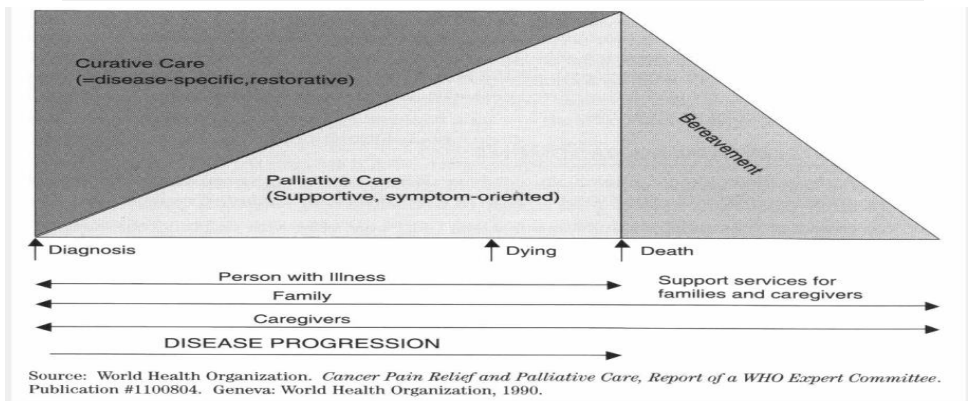
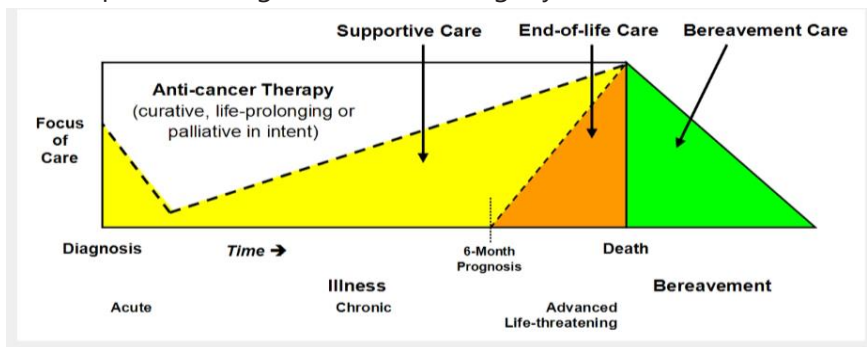
Penyakit Kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel/jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat tidak terkendali dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita.

Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran (metastasis) sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ, dalam perjalanan selanjutnya tumbuh dan menggandakan diri sehingga membentuk massa tumor.(Kemkes)

Pelayanan paliatif pasien kanker adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama serta pengobatan nyeri dan masalah masalah lain, baik masalah fisik, psikososial dan spiritual (WHO, 2002), dan pelayanan masa duka cita bagi keluarga (WHO 2005).

Pelayanan paliatif pasien kanker anak adalah pelayanan aktif, menyeluruh meliputi badan, pikiran, semangat anak serta melibatkan dukungan pada keluarganya, dimulai sejak diagnosis ditegakkan dan terus berlanjut; terlepas pasien anak menerima perlakuan seperti dimaksud dalam standar penanganan

penyakitnya; yang bertujuan untuk mencapai kualitas hidup terbaik bagi anak dan keluarganya. (WHO, 1998)



Gambar 1.1 Integrated model including both curative and paliative care for chronic progressive illness

Skema di atas menunjukkan bahwa perawatan paliatif dapat dimulai sejak diagnosis kanker ditegakkan atau bahkan ketika diagnosa belum ditegakkan, bila pasien mengalami penderitaan. Skema tsb juga menggambarkan bahwa perawatan paliatif memiliki peranan yang semakin besar dengan perjalanan penyakit yang semakin lanjut.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ataupun paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Rumah Paliatif adalah tempat perawatan pasien yang membutuhkan pelayanan paliatif berupa Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dan merupakan jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama. Stadium Lanjut adalah suatu tahapan penyakit dengan tujuan pengobatan untuk memperpanjang harapan hidup, bukan untuk penyembuhan.

Stadium Terminal adalah stadium lanjut yang tidak merespon pengobatan yang diberikan dan penyakitnya mengalami progresifitas menuju akhir kehidupan dan kematian. Hospis adalah jenis pelayanan pasien kanker stadium terminal dengan suasana lingkungan rumah tinggal pasien. Konsep ini dapat dilakukan di suatu institusi tersendiri, atau di rumah sakit (hospital based hospis).

Pelayanan holistik adalah pelayanan yang meliputi semua aspek kehidupan, yaitu fisik, psikologis, sosial, kultural dan spiritual. Pelayanan interdisipliner adalah pelayanan yang dilakukan oleh tim multidisipliner yang bekerja sama

untuk menentukan, mencapai, dan mengevaluasi tujuan program paliatif

Kondisi Penyakit Terminal (stadium lanjut) adalah penyakit yang tidak lagi respon terhadap terapi kuratif dengan harapan hidup terbatas dengan perburukan yang tidak dapat dikembalikan seperti adanya metastase, penurunan fungsi organ dan kualitas hidup. Harapan hidup kurang dari 12 bulan.

Kondisi pasien end of life adalah kondisi dimana telah terjadikemungkinan kematian semakin jelas yang ditandai adanya perburukan faktor fisik dan psikologis secara cepat dan juga terjadi peningkatan symptom (keluhan). Harapan hidup kurang dari 12 bulan. Dying process (akhir kehidupan) adalah fase akhir kehidupan menjelang kematian yang terjadi dalam beberapa jam atau hari (maksimal 14 hari-12 hari)

C. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Paliatif

Filosofi pelayanan paliatif adalah bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik sampai akhir hayat dan bahwa mengurangi penderitaan menjadi hal yang sangat penting dalam setiap layanan kesehatan ketika usaha untuk mencapai kesembuhan tidak lagi memungkinkan.

Pelayanan paliatif berfokus pada penatalaksanaan gejala, komunikasi tentang tujuan pengobatan yang selalu mengikuti perjalanan kondisi dan perjalanan penyakit, dan dukungan kepada pasien dan keluarga. Pelayanan paliatif berperan dalam membantu memberikan informasi tentang

fase akhir kehidupan, mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarga dan membantu mempersiapkan kebutuhan penatalaksanaan fase akhir kehidupan.

D. Indikasi

Indikasi pelayanan paliatif

Pelayanan paliatif dimulai sejak diagnosis kanker ditegakkan bila didapatkan satu atau lebih kondisi di bawah ini :

1. Nyeri atau keluhan fisik lainnya yang tidak dapat diatasi
2. Stres berat sehubungan dengan diagnosis atau terapi kanker
3. Penyakit penyerta yang berat dan kondisi sosial yang diakibatkannya
4. Permasalahan dalam pengambilan keputusan tentang terapi yang akan atau sedang dilakukan
5. Pasien/keluarga meminta untuk dirujuk ke perawatan paliatif
6. Angka harapan hidup < 12 bulan (ECOG > 3 atau Karnofsky < 50%, metastasis otak, dan leptomeningeal, metastasis di cairan interstisial, vena cava superior sindrom, kaheksia, serta kondisi berikut bila tidak dilakukan tindakan atau tidak respon terhadap tindakan yaitu: kompresi tulang belakang, bilirubin $\geq 2,5$ mg/dl, kreatinin ≥ 3 mg/dl). *tidak berlaku pada pasien kanker anak
7. Pada pasien kanker stadium lanjut yang tidak respon dengan terapi yang diberikan .

E. Lima kelompok besar yang digunakan untuk mengklasifikasikan kanker yaitu karsinoma, sarkoma, limfoma, adenoma dan leukemia (National Cancer Institute, 2009).

1. Karsinoma ialah kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ internal.
2. Sarkoma ialah kanker yang berasal dari tulang, tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, atau jaringan ikat.
3. Limfoma ialah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh.
4. Adenoma ialah kanker yang berasal dari tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan jaringan kelenjar lainnya.
5. Leukemia ialah kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang dan sering menumpuk dalam aliran darah.

F. Prinsip Keperawatan

1. Affirm life and regards dying as normal process (memegang teguh kehidupan dan kematian sebagai proses normal).

Perawatan paliatif sangat menghormati kehidupan, dan memandang kematian adalah bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, pasien dengan kondisi apapun tanpa memperhatikan berapa umur yang tersisa akan diperlakukan dengan baik. Perawatan paliatif mengajak pasien untuk dapat menghargai kehidupan, dan mengisi sisa waktu yang ada dengan berkualitas, seperti dengan menyelesaikan masalah masalah yang masih ada, dan

mencapai harapan yang masih ingin dicapai secara rasional.

2. Aims to neither hasten nor postpone death (tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian).

Perawatan Paliatif bukanlah Eutanasia. Tindakan yang dilakukan atau tindakan yang tidak dilakukan bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien dan mengurangi beban keluarga, dan bukan untuk mempercepat kematian atau menghambat proses kematian. Kematian diijinkan berlangsung selama alamiah. Sehingga ketika penyakit berlangsung progresif dan penyebab kematian tidak dapat diatasi, segala tindakan yang tidak bermanfaat mungkin dapat dihentikan atau tidak diberikan.

3. Gives the patient a central role in decision making (memberikan pasien peranan yang terpenting dalam menempatkan pengambilan keputusan).

Dalam perawatan paliatif, pasien memiliki hak untuk menentukan tindakan apa yang akan dijalani atau tidak akan dijalani dan turut dalam pengambilan keputusan dalam rencana perawatan. Dengan demikian, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi dengan pasien dan keluarga berdasarkan prinsip pasien memiliki hak untuk mengetahui kondisi sebenarnya, tetapi juga berhak untuk tidak mengetahui bila dikehendaki. Informasi yang diberikan diharapkan agar pasien mampu memahami kondisi apa yang terjadi, menerima dan beradaptasi dengan segala keterbatasan yang

ditimbulkan oleh kondisi yang ada. Bila kondisi pasien tidak lagi memungkinkan untuk mengambil keputusan karena kemampuan kognitifnya menurun, keluarga yang ditunjuk oleh pasien akan menggantikan perannya. Hal ini seringkali tidak mudah bagi keluarga. Oleh karena itu, dalam perawatan paliatif, Advanced Care Planning sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum kondisi pasien tidak mampu membuat keputusan.

4. Provide relief from distressing symptoms (memberikan tata laksana gejala yang menimbulkan stres).

Tujuan perawatan paliatif yang terutama adalah mengurangi penderitaan pasien. Nyeri dan gejala fisik lain yang tidak tertangani dengan baik adalah sumber penderitaan pasien dan keluarga. Di dalam perawatan paliatif, nyeri dikategorikan dalam kondisi darurat yang harus segera mendapatkan tatalaksana. Bila tidak, nyeri akan menimbulkan atau memperberat gejala fisik lain seperti mual/muntah, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, gangguan mobilisasi dan dalam melakukan aktifitas yang pada akhirnya mengurangi kualitas hidup pasien dan meningkatkan beban keluarga. Sebaliknya, nyeri akan meningkat bila gejala lain tidak tertata laksana dengan baik. Penyebab nyeri atau gejala lain pada pasien kanker dapat diakibatkan oleh kanker itu sendiri, tindakan diagnosa atau pengobatan yang diberikan, kondisi tirah baring dan komorbiditas.

5. Integrates the psychological, emotional, spiritual and sosial aspects of care for the patients, the family and carers in a culturally sensitive manner (mengintegrasikan aspek psikologis, emosi, spiritual dan sosial bagi pasien dan keluarganya serta pelaku rawat dengan memperhatikan aspek kultur yang dipegang oleh pasien dan keluarga).

Aspek psikologis, sosial, spiritual dan aspek fisik tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing masing saling berhubungan dan mempengaruhi. Gejala fisik tidak dapat tertangani baik tanpa memperhatikan dan menatalaksana gangguan psikologis, kesulitan sosial dan masalah spiritual. Oleh karena itu, semua aspek diatas harus diperhatikan dan ditatalaksana secara terintegrasi untuk mencapai tujuan perawatan paliatif yaitu mencapai kualitas hidup dan meninggal dengan bermartabat

6. *Avoids futile interventions* (menghindari intervensi yang sia-sia).

Kualitas meninggal menjadi salah satu ciri dan tujuan dalam perawatan paliatif. Namun kematian masih sering dianggap sebagai suatu kegagalan, baik oleh tenaga kesehatan maupun keluarga. Kematian seolah olah dianggap sebagai musuh, sehingga harus dicegah. Memberikan tindakan maksimal seringkali dianggap melakukan hal terbaik oleh keluarga ketika menghadapi kematian. Selain itu, sebagian besar dokter terus berusaha agar pasien tidak meninggal sehingga memberikan apa saja yang bisa menghentikan proses

kematian. Tanpa disadari kita mungkin telah sering memberikan tindakan yang sia sia, yang menambah penderitaan pasien demi usaha kita mencegah proses kematian. Bila hal itu terjadi, pasien kehilangan kesempatan untuk dapat meninggal secara alamiah.

7. *Offers a support system to help patients live as actively as possible until death* (menyediakan sistem dukungan untuk membantu pasien dapat hidup seaktif mungkin sampai meninggal).

Dalam Perawatan Paliatif, pasien dianjurkan untuk dapat mandiri dan dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kondisi yang ada. Dengan demikian pasien akan memiliki semangat untuk bertahan karena dihargai haknya dan diberi kesempatan untuk melakukan apa yang bisa dan ingin dilakukan. Dengan melakukan hal tsb, tanpa disadari pasien mampu bertahan hidup lebih lama.

8. *Offers a support system to help the family and carers coping during the patient's illness and after the patient's death* (memberikan sistem dukungan untuk membantu keluarga dan pelaku rawat dalam menghadapi kondisi yang ada selama sakit dan setelah pasien meninggal).

Klien dalam perawatan paliatif bukan hanya pasien tetapi juga keluarganya. Setelah pasien meninggal, beban dan penderitaan keluarga mungkin belum selesai. Pendampingan oleh tim paliatif diperlukan agar keluarga dapat menerima kepergian tersebut dengan baik, dan mampu beradaptasi dengan kehidupan baru tanpa

almarhum/almarhumah. Pendampingan dilakukan samapi masa duka cita berakhir, yang biasanya berlangsung 13 bulan setelah pasien meninggal.

9. Uses a team approach to address the needs of patients and their care givers (Menggunakan pendekatan tim dalam memenuhi kebutuhan pasien dan pelaku rawat).

Penderitaan yang dialami pasien dan beban yang ditanggung keluarga akibat penyakit kanker sangat kompleks. Oleh karena itu diperlukan tim paliatif yang terdiri dari berbagai disiplin dan profesi. Tim paliatif berpijak pada pengertian yang sama tentang kondisi pasien akan bersama sama menentukan tujuan perawatan paliatif bagi masing masing pasien dan keluarga. Karena kondisi pasien bersifat dinamis, tujuan perawatan mungkin akan berubah disesuaikan dengan tahapan dalam fase paliatif.

G. Pelayanan Paliatif meliputi kegiatan:

1. Tatalaksana Nyeri

Di bagi menjadi tatalaksana terapi farmakologi dan nonfarmakologi

- a. Terapi farmakologik dilakukan dengan pendekatan "tangga analgetik WHO" (WHO pain relief ladder) yang dimodifikasi, dimana terdapat 4 (empat) anak tangga dan masing-masing anak tangga mewakili derajat nyeri serta terapinya. Semakin tinggi anak tangga mencerminkan derajat nyeri yang makin hebat.
- b. Terapi Non Farmakologik

2. Tatalaksana keluhan fisik lain Beberapa gejala fisik yang sering dialami oleh pasien kanker antara lain sesak nafas. Manajemen sesak nafas diberikan dengan memperhatikan penyebab sesak nafas dan aspek psikologis, sosial dan spiritual yang dilakukan secara multidisiplin dengan menggunakan modalitas farmakologi dan non farmakologi.
3. Dukungan psikologis, Memberikan dukungan psikologis merupakan bagian integral dalam perawatan paliatif.

Prinsip dalam memberikan dukungan psikologis antara lain:

- a. Kenali gejala cemas dan depresi.
- b. Lakukan asesmen gangguan psikologis berupa cemas dan depresi dengan alat ukur yang ditentukan dan ditata laksana sesuai kebutuhan.
- c. Kenali dan hormati coping mechanism yang dimiliki pasien dan keluarga.
- d. Tanyakan status emosional, namun pasien tidak dipaksa untuk mendiskusikan masalah psikologis yang dialami.
- e. Berikan dukungan psikologis yang diperlukan karena hal ini bersifat dinamis dengan berjalannya penyakit, perlu dengan hati hati didiskusikan dengan pasien dan keluarga.
- f. Perhatikan faktor kultural dalam memberikan dukungan psikologis.

4. Dukungan Sosial ditinjau dari aspek sosial pasien dengan perawatan paliatif, hubungan dengan keluarga dan pekerjaan, nilai-nilai yang dianut pada keluarga pasien, aspek finansial, serta mekanisme adaptasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar pasien merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi konsep terjadinya keluhan pada pasien. Dukungan sosial harus memperhatikan:
 - a. Menghormati nilai dan martabat pasien dan keluarga yang berhubungan dengan integritas fisik, psikologis, sosial dan spiritual serta kesejahteraan.
 - b. Otonomi dan partisipasi sesuai dengan kekuatan dan ketanggungan dan sebagai pribadi yang utuh dalam lingkungannya.
 - c. Keadilan sosial bagi individu dan masyarakat sebagai kesatuan, dan komitmen terhadap keberagaman kultur dan kebutuhan advokasi.
 - d. Kerahasiaan terhadap aspek personal dalam kehidupan dan informed consent.
 - e. Asesmen dalam aspek sosial meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual pasien dan keluarga untuk mengidentifikasi sumber-sumber kekuatan, ketanggungan, masalah dan kebutuhan praktis dapat menggunakan alat penilaian dengan mengandalkan komunikasi, hubungan yang baik, dan cara berpikir kritis.
 - f. Asesmen meliputi dampak penyakit pada kondisi dan keseimbangan keluarga; hubungan interpersonal dalam keluarga termasuk masalah perkawinan,

kesepakatan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, hubungan dengan orang lain. Perubahan peran dan tanggung jawab dalam keluarga, masalah finansial, aspek legal dalam pembuatan amanah dan warisan (Do Not Resuscitation/DNR, ritual pemakaman, donor organ, pendidikan anak atau acara-acara penting keluarga, dan lain-lain).

- g. Dukungan sosial dilakukan dengan melibatkan sumber-sumber yang ada dalam diri pasien, keluarga dan masyarakat; Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berfungsi advokasi dan membantu mencari dan bekerjasama dengan sumber-sumber tersebut.

5. Dukungan Spiritual

Meletakkan aspek spiritual pasien merupakan komponen yang fundamental di kualitas pelayanan paliatif. Spiritualitas bukan semata-mata masalah agama, tetapi meliputi makna dan tujuan hidup. Spiritualis seseorang dibentuk oleh agama yang diyakini, kultur dan kebiasaan dalam keluarga dan dimodifikasi oleh pengalaman hidup. Hal ini yang menjadi dasar sikap, nilai, keyakinan dan tindakan yang dilakukan. Spiritualitas menjadi nyata saat seseorang mengalami penyakit terminal.

Ditinjau dari aspek spiritual, pada akhirnya keluarga dan tim paliatif adalah sebagai pendamping dalam menghadapi kematian sehingga pada akhirnya menjadi kematian yang damai, nyaman dan bermartabat sesuai keyakinan yang dimiliki.

Dalam memberikan dukungan spiritual, perlu diperhatikan hal-hal antara lain:

- a. Asesmen terhadap aspek spiritual yang berhubungan dengan masa lalu: arti kehidupan masa lalu, hubungan di masa lalu, pencapaian, kenangan yang menyakitkan atau memalukan, rasa bersalah dan penyesalan, kegagalan mencapai sesuatu.
 - b. Kondisi dan kebutuhan spiritual yang berhubungan dengan saat ini: integritas diri, ketergantungan terhadap orang lain, perubahan status sosial, arti penderitaan yang dialami, dan tujuan hidup.
 - c. Kekhawatiran akan masa yang akan datang: perpisahan dengan orang yang dicintai, rasa tidak ada harapan, tidak berarti, dan ketakutan akan kematian.
 - d. Aspek yang berhubungan dengan agama: harapan, pengampunan dosa, hukuman, kehidupan yang akan datang, dan sumber-sumber yang dapat memberikan dukungan secara keyakinan. Dukungan spiritual dapat dilakukan oleh semua anggota tim paliatif, namun aspek keagamaan atau keyakinan secara khusus dilakukan oleh rohaniawan sesuai agama/keyakinan pasien dan atau keluarga.
6. Perencanaan perawatan di masa mendatang (advance care planning)

Perencanaan perawatan di masa mendatang (*Advance Care Planning/ACP*) adalah suatu proses dinamis rencana perawatan masa depan yang merupakan

diskusi berkelanjutan antara pasien dan orang yang merawatnya, keluarga serta tenaga kesehatan (dokter/perawat) mengenai nilai dan kepercayaan pasien, serta pilihan perawatan dan pengobatannya.

Perencanaan perawatan di masa mendatang dapat berupa advance directive.

Advance Directive adalah pernyataan tertulis berisi keinginan pasien atas perawatan kesehatan baginya di kemudian hari (advance directive) yakni dokumen hukum yang menyatakan pilihan pasien mengenai perawatan medis yang ingin diterima/ditolaknya saat pasien tidak berkompeten untuk mengambil keputusan. Secara legal, maka hirarki pengambil keputusan yang berhak mewakili pasien adalah wali yang dikuasakan, pasangan (suami/isteri de facto), anak, orang tua, saudara kandung, pengasuh, kerabat dekat lain.

Perencanaan perawatan di masa mendatang dapat termasuk antara lain:

- Penunjukan pihak ke tiga yang akan bertindak atas nama pasien dalam pengambilan keputusan ketika pasien tidak mampu membuat keputusan; Perencanaan Do Not Resuscitate (DNR), tindakan invasif, dan atau tindakan penopang kehidupan lainnya di Rumah Sakit; Donasi organ, jaringan atau tubuh; dan Wasiat.

7. Perawatan akhir kehidupan (Bereavement Care)
 - a. Perencanaan perawatan akhir kehidupan ditujukan bagi pasien menjelang proses kematian sampai kematian. Pasien pada saat menjelang proses kematian ditetapkan berdasarkan asesmen sesuai dengan panduan yang berlaku dan sesuai yang ditetapkan oleh pasien dalam perawatan di masa mendatang.
 - b. Tujuan perawatan akhir kehidupan adalah untuk mencapai kenyamanan, kedamaian dan kematian bermartabat serta dan dalam iman sesuai kepercayaan pasien serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan antara lain euthanasia dan assisted suicide.
 - c. Perencanaan perawatan akhir kehidupan termasuk keputusan tidak dilakukan resusitasi (DNR) dilakukan oleh pasien atau keluarga. Perawatan paliatif memandang kematian sebagai bagian dari kehidupan, dan proses normal. Akhir kehidupan perlu dipersiapkan untuk mencapai sisa kehidupan yang berkualitas dan kematian yang damai dan bermartabat melalui layanan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi pasien dan memperhatikan pilihan pasien. Yang dimaksud dengan stadium terminal adalah tahapan akhir stadium lanjut, pada saat semua modalitas yang diberikan tidak mampu Penegakan diagnosa stadium terminal penting agar pasien tidak terbebani oleh terapi atau tindakan lain yang sia-sia (tidak menyelamatkan jiwa, tidak memperpanjang usia, tidak meningkatkan kualitas

hidup), dan kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual terpenuhi.

8. Dukungan dan persiapan selama masa duka

Rasa duka akibat kehilangan seseorang yang dicintai atau dekat secara emosional, tidaklah ringan. Rasa kehilangan dapat menyebabkan kemunduran atau timbulnya gangguan jiwa bila tidak terselesaikan dengan baik atau sebaliknya menyebabkan meningkatnya kematangan kepribadian seseorang bila masa duka ini teratasi dengan baik. Karena itu dukungan di masa duka cita dianggap sangat penting. Rasa duka akibat perpisahan yang akan terjadi, juga dialami oleh pasien yang dalam keadaan terminal.

Duka cita mempunyai 3 tahapan yaitu,

- a. Tahap syok, rasa hampa dan rasa tidak percaya (shock-numbness and denial). dimana sebaiknya yang berduka dibiarkan mengeluarkan isi hatinya(ventilasi).
- b. Tahap kedua, rasa kehilangan dan kesepian (acute mourning). Ditahap ini rasa kesepian makin menjadi dan sangat menyakitkan. Rasa bingung akan kemampuan diri untuk hidup tanpa kehadiran yang meninggal. Rasa kacau dengan bayang-bayang silih berganti antara momen bersama yang gembira maupun duka. Rasa ingin memenuhi semua yang belum terselesaikan bersama. Tahap ini adalah tahap yang sangat menentukan, tahap krisis, dimana bila pendampingan dan respons yang berduka baik maka akan cepat beralih ke tahap berikutnya

Cara mengatasi dengan Non Farmakologis segera mengisi kesepian dan rasa kehilangan dengan pendampingan yang penuh kasih sayang.

Tugas-tugasyang harus diselesaikan adalahsebagai berikut:

Tugas 1 : belajar menerima kenyataan.

Tugas 2 : belajar mengatasi rasa sepi dan nyeri(pilu).

Tugas 3 : belajar menyesuaikan diri dalamlingkungan baru tanpa kehadiranyang meninggal.

Tugas 4 : merelokasi bayangan yangmeninggal dalam kenangan yangmanis dan melangkahdalam hidupbaru.

Tugas 5: meningkatkan keimanan tanpa kehadiran sosok yang meninggal.

- c. Tahap penyembuhan atau tahap restitution, dimana yang berduka mulai berusaha kembali ke fungsi harian yang normal dan belajar kehidupan baru tanpa kehadiran yang meninggal.

Dukungan yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Menghormati nilai dan martabat yang meninggal dunia dan keluarganya yang berhubungan dengan ekspresi duka sesuai personal, budaya setempat dan faham spiritual.
- 2) Menghargai keputusan yang ditentukan keluarga dalam prosesi pemakaman.
- 3) Mewaspadaai gejala duka cita yang abnormal antara lain:
 - a) Duka cita berlebihan (exagerated grief), karena tanpa disadari akan mencederai diri atau

kurangnya asupan makan minum. Hal ini juga perlu diwaspadai dengan memperhatikan apakah agresifitas itu masih dalam alam realita, karena ditakuti adanya keadaan psikosis.

- b) Duka cita yang tertunda (delayed grief), yang sangat ditakuti adalah duka cita terjadi setelah peziarah sudah meninggalkan yang sedang berduka tanpa pendampingan.
- c) Dukacita tersamar (masked grief), dukacita sejenis ini tersamar dengan keluhan fisik atau keluhan fungsi kognitif yang sering baru diketahui setelah parah.
- d) Dukacita yang kronis (Complicated grief), adalah duka cita yang berlangsung lebih dari masa penyesuaian yaitu lebih dari 6 bulan dengan gejala hampir sama dengan awal tahap duka cita.
- e) Perubahan ekspresi duka cita yang berfokus pada rasa kehilangan beserta dampaknya dan rasa sepi akibat ditinggal berubah menjadi ekspresi menyalahkan diri sendiri atas kematian tersebut, kegagalan merawat diri, merasa diri tidak berharga, apalagi tidak pantas untuk hidup lagi, karena hal ini kemungkinan berlanjut ke kecenderungan bunuh diri atau gangguan depresi berat (major depressive disorder).
- f) Perubahan pola tidur yang biasanya sesekali datang dengan ekspresi rasa kehilangan dan kerinduan akibat ditinggal orang yang dekat,

menjadi mimpi-mimpi buruk yang menegangkan, gambaran kilas balik tentang detik-detik kematian itu sendiri yang menyebabkan gejala panik, maka kemungkinan gejala tersebut akan berlanjut ke gangguan stres pasca trauma (post traumatic stress disorder).

g) Timbulnya kebiasaan baru yang kurang patut bahkan buruk, misalnya menolak makan atau sebaliknya makan berlebihan (binge eating), merokok, meminum obat berlebihan dengan berbagai alasan.

9. Penyelenggaraan pelayanan paliatif di rumah sakit dilakukan oleh tim paliatif dengan pendekatan interdisiplin yang terdiri dari berbagai disiplin dan spesialisasi, antara lain:

- a. dokter spesialis
- b. dokter
- c. perawat
- d. apoteker
- e. psikolog klinis
- f. fisioterapis
- g. nutrisi
- h. kader
- i. relawan
- j. pelaku rawat (care worker)
- k. rohaniawan
- l. pekerja sosial medis

SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan paliatif.

H. Kesimpulan

Pelayanan paliatif pasien kanker adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama serta pengobatan nyeri dan masalah masalah lain, baik masalah fisik, psikososial dan spiritual dan pelayanan masa duka cita bagi keluarga. Pelayanan paliatif berfokus pada penatalaksanaan gejala, komunikasi tentang tujuan pengobatan yang selalu mengikuti perjalanan kondisi dan perjalanan penyakit, dan dukungan kepada pasien dan keluarga. Pelayanan paliatif berperan dalam membantu memberikan informasi tentang fase akhir kehidupan, mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarga dan membantu mempersiapkan kebutuhan penatalaksanaan fase akhir kehidupan.

Dalam melakukan pelayanan paliative berorientasi pada prinsip prinsip pelayanan paliative

Paliatif meliputi kegiatan: Tatalaksana nyeri Yang di bagi menjadi menjadi tatalaksana terapi farmakologi dan nonfarmakologi, tatalaksana keluhan fisik lain, dukungan psikologis, Pelayanan dukungan spiritual, Perencanaan perawatan di masa mendatang (advance care planning), Perawatan akhir kehidupan (Bereavement Care)

Perencanaan perawatan akhir kehidupan ditujukan bagi pasien menjelang proses kematian sampai kematian. Pasien pada saat menjelang proses kematian ditetapkan berdasarkan asesmen sesuai dengan panduan yang berlaku dan sesuai yang ditetapkan oleh pasien dalam perawatan di masa mendatang.

Penyelenggaraan pelayanan paliatif di rumah sakit dilakukan oleh tim paliatif dengan pendekatan interdisiplin yang terdiri dari berbagai disiplin dan spesialisasi, yang disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan paliatif.

I. Referensi

ACP: Advance Care Planning

Cancer Council. 2019. Living with Advanced Cancer; A guide for people with cancer, their families and friends (J. Mothoneos (ed.)). Cancer Council Australia

DNA: Deoksiribonukleat Acid

DNR: Do Not Recustitation

ECOG: Eastern Cooperative Oncologi Group

Globocan. 2012. 2012. "No TitleEstimatedCancer Incidence, Mortality,Prevalence and Disability-Adjusted Life Years (DALYs) Worldwide in 2008."

Globocan: Global Burden of Cancer Study

Glosarium

Kemenkes RI. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pelayanan Paliative Kanker, 2013

Kemenkes RI. Undang-Undang Republik Indonesia No 2180 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelayanan paliatif . 2023.

Kemenkes, R I. 2018. "Hasil Utama RISKESDAS 2018." Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2022. "Panduan Pelaksanaan Hari Kanker Sedunia 2022." :1–17. [https://promkes.kemkes.go.id/download/ftjl/files90159BUKU_PANDUAN_HKS_2022_\(3\).pdf](https://promkes.kemkes.go.id/download/ftjl/files90159BUKU_PANDUAN_HKS_2022_(3).pdf).

Kementerian Kesehatan. Pedoman Nasional Pelayanan Paliatif Kanker. 2015. [Internet] Available from: <https://p2ptm.kemkes.go.id/dokumenptm/pedoman-nasional-m-paliatif-kanker>

Kemkes: Kementraian Kesehatan

Munandar, Arif., Andini, N.K.S, dkk. (2022). Keperawatan Paliatf (Konsep dan Penerapan). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

National Coalition for Hospice and Palliative Care. (2018). Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care, 4th edition. Richmond, VA: National Coalition for Hospice and Palliative Care

PSM: pekerja sosial Masyarakat

UKBM: Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

WHO: World Health Organization

World Health Organization (WHO). Palliative Care. 2020. [Internet]. Available from: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/palliative-care>

World Health Organization (WHO). Planning and implementing palliative care services: a guide for programme managers. Geneva: WHO Library Cataloguing; 2016. 1-79 p.

CHAPTER 2

PERAN PERAWAT DALAM EDUKASI NUTRISI UNTUK PASIEN KANKER

Ns. Nur Fithriyanti Imamah, MBA., Ph.D.

A. Pendahuluan/Prolog

Kanker mengalami jumlah peningkatan kasus tahun demi tahun, termasuk di negara dengan pendapatan menengah ke bawah dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Beberapa jenis kanker yang mayoritas terjadi di seluruh dunia antara lain kanker payudara pada wanita; kanker paru; dan kanker prostat. Salah satu kanker yang menyebabkan kematian tertinggi adalah kanker paru, diikuti oleh kanker liver dan kanker perut (Ferlay et al., 2021).

Kanker dapat terjadi pada semua kalangan usia. Kanker yang umum terjadi pada anak dan remaja antara lain adalah kanker darah, kanker tulang, dan kanker otak. Kanker pada usia dewasa umumnya adalah kanker paru, kanker prostat, kanker payudara, kanker serviks, kanker nasofaring (KNF), kanker paru, dan lainnya (NIH, 2021). Lansia juga memiliki kemungkinan untuk mengalami kanker diakibatkan oleh perubahan fungsi fisiologis yang menua. Beberapa pertimbangan untuk tidak melakukan pengobatan yang dapat membantu sel kanker adalah kemungkinan memburuknya kondisi pasien secara umum, terutama

penurunan kualitas hidup (DeSantis et al., 2019, Estapé, 2018).

Nutrisi bagi pasien kanker penting untuk kesembuhan klien. Pemenuhan nutrisi membantu pemulihan yang baik dan toleransi terhadap terapi. Nutrisi yang terpenuhi secara langsung dapat meningkatkan kesehatan fisik klien dimana akhirnya akan berdampak pada fungsi psikologis dan sosial klien yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup. (Liebermann et al., 2023).

Terapi kanker merupakan terapi yang melelahkan dan meninggalkan efek samping, termasuk kepada masalah nutrisi berupa mual muntah, diare, konstipasi, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan (Estapé, 2018). Pada pasien kanker paru yang menjalani kemoterapi, tiga gejala umum yang ditemukan adalah fatig, penurunan nafsu makan, dan nausea (Zheng et al., 2024). Masalah nutrisi pada pasien kanker jika tidak ditangani akan memperparah kondisi penyakit dan menurunkan kualitas hidup (DeSantis et al., 2019).

Peran perawat dalam nutrisi pasien kanker memiliki peranan penting dalam menentukan intervensi yang sesuai dengan keadaan pasien. Perawat dapat kolaborasi dengan ahli gizi mengevaluasi status nutrisi klien, dan menentukan diet yang tepat. Lebih lanjut, perawat diharapkan memberikan edukasi jangka panjang mengenai masalah nutrisi secara lengkap agar dapat mencegah keadaan malnutrisi dan kaheksia (Liebermann et al., 2023, Dowling et al., 2024, Hopkinson, 2023).

Beberapa penanganan yang telah diberikan untuk menangani masalah nutrisi pasien kanker antara lain pendekatan secara farmakologis kolaborasi dengan dokter untuk menangani gejala yang timbul. Pengkajian kesehatan juga dilakukan untuk menganalisa masalah nutrisi yang dialami. Pengembangan berupa monitoring kesehatan secara berlanjut dengan menggunakan komputer juga dilakukan untuk memonitor kesehatan pasien kanker yang berada di luar rumah sakit (Liebermann et al., 2023, Reid et al., 2024, Rogers et al., 2023).

B. Masalah Nutrisi Pasien Kanker

1. Masalah nutrisi yang umum dialami

Masalah nutrisi pada pasien kanker umumnya timbul akibat dari terapi yang didapatkan. Masalah nutrisi dapat timbul menyerang organ pencernaan mulai dari mulut sebagai organ awal pencernaan makanan sampai dengan rektum, organ terakhir yang berfungsi dalam proses eliminasi makanan.

Pada mulut, umumnya, pasien akan mengalami stomatitis, xerostomia, dan disfagia. Berkurangnya produksi air liur di dalam mulut menyebabkan tingginya potensi kuman berkembang di area mulut. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan mulut secara umum sehingga dapat menyebabkan radang pada mukosa mulut bahkan ke gigi. Berkurangnya air liur nantinya berdampak kepada kemampuan klien

dalam mencerna makanan di mana kemungkinan klien akan merasa kesulitan dalam menelan baik menelan makanan dan air minum. Pada keadaan ini, pemberian nutrisi secara parenteral akan sangat membantu pemenuhan nutrisi (Tuominen et al., 2023, Kara et al., 2023).

Efek lebih lanjut yang timbul pada sistem pencernaan adalah rasa mual, dan muntah, bahkan penurunan nafsu makan. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, penurunan berat badan merupakan hal yang tak mungkin lagi dihindarkan. Gangguan yang terjadi pada organ usus dapat menyebabkan kemungkinan pasien mengalami diare atau bahkan konstipasi. Hal ini mungkin menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan elektronik jika tidak tertangani dengan baik. Kolaborasi pemberian obat farmakologis untuk menangani gejala yang dialami adalah hal utama yang dapat membantu mengontrol gejala. Sebagai pendukung, pengaturan ulang mengenai diet yang diperlukan bagi pasien dapat dilaksanakan bersama dengan ahli gizi (Röhl et al., 2019, Erickson et al., 2025).

Masalah lain yang mungkin dialami oleh pasien kanker adalah kekurangan zat besi ditandai dengan sulit bernafas, kelelahan, letargi, sakit kepala,

palpitasi dan nyeri dada. Umumnya, hal ini terjadi pada pasien kanker gastrointestinal seperti kanker usus. Penambahan zat besi menjadi penting untuk mencegah kondisi keparahan yang nantinya dapat menyebabkan kematian (Reid et al., 2024).

2. Masalah nutrisi pada pasien khusus

Masalah nutrisi kanker pada kelompok khusus adalah masalah nutrisi pada klien kanker pada beberapa keadaan yang rentan, seperti anak kecil, wanita menopause, dan lanjut usia (Lansia).

Pada klien anak, yang seringkali belum memahami dengan baik masalah kesehatan yang terjadi pada dirinya, seringkali membuat gejala berkaitan dengan masalah nutrisi tidak dilaporkan secara rinci dan detail kepada petugas kesehatan. Komunikasi dengan orang tua dan juga pengasuh menjadi kunci untuk menggali masalah nutrisi yang dialami oleh klien.

Salah satu pertimbangan khusus pada pasien anak dengan leukemia mieloid akut, penanganan yang diutamakan untuk terapi nutrisi adalah penanganan melalui jalur enteral. Pasien anak dengan permasalahan nutrisi tidak hanya mengalami masalah secara fisik, namun juga mengalami kehilangan kemandirian, keterbatasan gerak, dan

ketakutan mengalami kenaikan berat badan yang tidak diinginkan (van Lieshout et al., 2022).

Strategi terapeutik utama untuk pasien anak dengan leukemia dan limfoma adalah kemoterapi, baik dalam kombinasi dengan atau tanpa terapi radiasi. Selain pengukuran antropometri yang menyimpang, kadar hemoglobin, dan kadar albumin serum, yang semuanya terkait dengan diet yang tidak memadai banyak dari individu ini sering menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi yang memengaruhi bibir, wajah, gigi, rambut, dan kulit mereka (Ibrahim and Fathi Zaghamir, 2024).

Pada wanita yang menopause, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah perubahan hormon. Sebuah studi menunjukkan bahwa survivor wanita menopause merasa perlu pola diet yang khusus menyesuaikan kebutuhan pada saat menopause. Klien mencari melalui online secara mandiri informasi diet yang dibutuhkan karena merasa kurang diinformasikan oleh tenaga kesehatan. Beberapa dari klien mengonsumsi suplemen nutrisi seperti zinc, magnesium, zat besi, dan kalsium untuk mendapat nutrisi yang cukup (Cushen et al., 2025)

Pada kalangan lansia, fenomena menunjukkan berbagai macam jenis kanker mungkin terjadi dengan jenis berbeda-beda di setiap golongan usia.

Resiko penyakit kanker paru dan melanoma misalnya, lebih banyak terjadi pada lansia dengan usia yang lebih tua (>84 tahun). Keterlambatan diagnosis umumnya menyebabkan lambatnya pasien untuk ditangani sehingga dapat menurunkan kemungkinan hidup pasien lansia. Pasien kanker lansia yang memiliki usia lebih dari 84 tahun memiliki tingkat kemungkinan hidup yang rendah disbanding dengan lansia yang berusia lebih muda darinya (DeSantis et al., 2019, Estapé, 2018).

Pada lansia dengan kanker, masalah nutrisi yang dihadapi adalah keadaan malnutrisi dimana kondisi biologis yang menunjukkan penuaan memperlambat penyembuhan penyakit. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menangani masalah nutrisi pada pasien kanker lansia adalah resiko tingginya kematian. Lebih lanjut, lansia yang memiliki tambahan penyakit berupa penyakit kronik menjadi faktor penyulit untuk mencapai kondisi nutrisi yang optimal (Hopkinson, 2015, DeSantis et al., 2019).

C. Peran Perawat

Peran perawat antara lain adalah:

1. Perawat Klinik

Sebagai perawat klinik, memberikan intervensi yang memadai adalah faktor pendukung penting untuk nutrisi klien yang baik. Untuk menentukan tindakan yang tepat, perawat klinik dapat melakukan pengkajian resiko malnutrisi dan mengatur rencana intervensi sesuai kebutuhan masing-masing klien. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan intervensi klinik antara lain (Hopkinson, 2015);

a. Status Penyakit

Penyakit kanker seringkali ditemui pada saat sudah tahap lebih lanjut dimana pengobatan memiliki kemungkinan kecil untuk membantu mengurangi sel-sel kanker (Estapé, 2018). Status penyakit menentukan bagaimana intervensi akan diberikan, apakah dia masih di tahap awal perkembangan penyakit, atau tahap lanjut.

b. Area Tubuh Yang Mengalami Kanker

Lokasi terjadinya kanker juga menentukan bagaimana tindakan keperawatan hendaknya diberikan. Misalnya, ketika kanker terjadi di beberapa titik anggota tubuh, maka perawat tidak dapat memberikan secara luas penanganan dibandingkan dengan hanya yang mungkin terjadi pada satu titik. (Hopkinson, 2015).

c. Penanganan atau Terapi Kanker yang digunakan

Jenis pengobatan yang digunakan atau terapi yang sedang diterima oleh pasien kanker juga akan menyebabkan perbedaan penanganan keperawatan (Hopkinson, 2015). Terapi yang didapat seperti kemoterapi, pembedahan, radiasi, imunoterapi, dapat menimbulkan efek samping yang berbeda bagi klien (Sharour, 2019).

d. Penyakit Penyerta

Adanya penyakit penyerta, terutama penyakit kronik seringkali menimbulkan efek pengobatan yang berbeda. Pertimbangan kondisi yang lebih parah pada klien dengan penyakit penyerta menjadi kehati-hatian dalam memilih intervensi yang akan diberikan (Etapé, 2018)

e. Usia

Usia adalah hal penting yang menjadi patokan bagaimana intervensi diberikan, dimana orang dengan lanjut usia mungkin memiliki fungsi fisiologis yang lebih payah dibandingkan dengan usia yang lebih muda (Etapé, 2018, Hopkinson, 2015). Pada anak dengan kanker darah misalnya, terapi yang lebih diutamakan adalah pemberian nutrisi melalui enteral dibandingkan dengan parenteral (van Lieshout et al., 2022).

f. Metode intervensi yang akan digunakan

Dalam memilih intervensi, kemudahan dan kesulitan dari pelaksanaan intervensi serta tempat pemberian layanan perlu dipertimbangkan dengan matang.

Intervensi nutrisi di rumah sakit mungkin akan berbeda dengan intervensi nutrisi yang dilaksanakan di rumah maupun komunitas (Liebermann et al., 2023).

g. Dukungan Keluarga atau ketersediaan sumber daya manusia pendukung

Faktor sosial menjadi pertimbangan yang besar dalam memilih tindakan keperawatan bagi klien. Klien dengan usia yang lebih tua, cenderung percaya dengan sebayanya dibandingkan dengan keluarganya (Etapé, 2018).

Secara umum, rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan perawat, khususnya perawat onkologi berkaitan dengan masalah nutrisi pada pasien berlangsung secara terus menerus. Dimulai dari pengkajian mengenai masalah nutrisi yang dialami oleh klien, lalu memberikan perawatan nutrisi yang dibutuhkan. Untuk mencegah keadaan yang tidak diinginkan, perawat juga dituntut untuk memonitor status nutrisi dan pelaksanaan perawatan nutrisi yang dilaksanakan. Harapannya, dengan memonitor status secara kontinyu dapat mempertahankan status nutrisi dalam rentang normal (Erickson et al., 2025).

Pengkajian dan konsultasi komprehensif kepada pasien, memantau dan menyelesaikan masalah selama pemberian makan enteral (seperti kembung perut, diare, muntah, dan aspirasi), dan mengatasi komplikasi pemberian makan parenteral (Zhao et al., 2021). Pengkajian secara komprehensif mengenai riwayat

timbulnya penyakit serta resiko yang menyebabkan kanker dapat membantu perawat memberikan penanganan yang tepat. Pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan klinik tambahan juga akan membantu menentukan kebutuhan terapi perseorangan (Liebermann et al., 2023).

Tindakan keperawatan yang dapat diberikan bagi klien kanker dengan masalah nutrisi antara lain kolaborasi pemberian antiemetik, pemberian terapi cairan melalui intravena, pemberian elektrolit serta penggunaan terapi non-farmakologis lainnya. Edukasi mengenai pentingnya nutrisi yang cukup sebagai penunjang agar kualitas hidup klien meningkat (Estapé, 2018).

Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk merawat pasien dengan gejala stomatitis adalah perawatan mulut. Perawat memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan perawatan mulut secara optimal, dikarenakan kurangnya waktu, pengetahuan mendalam mengenai perawatan mulut, dan kekurangan jumlah tenaga (Zuo et al., 2024).

Sebuah intervensi keperawatan dirancang untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit baik karena kondisi gawat darurat maupun kunjungan rawat jalan. Intervensi dirancang untuk menggali dan membantu menyelesaikan masalah pemberian nutrisi parenteral yang terjadi ketika pasien dirawat di rumah. Evaluasi hasil keperawatan menunjukkan konsultasi yang intens akhirnya membantu hampir semua masalah teratasi sehingga intervensi dinilai efektif dan dapat diuji coba

oleh perawat lainnya dengan klien yang sama (Rogers et al., 2023).

Intervensi lain dirancang untuk menangani masalah anemia pada pasien kanker menggunakan pelaporan berbasis computer mengenai tingkat keparahan anemia, memberikan tambahan zat besi yang diberikan secara oral, dan parenteral jika tidak memadai diberikan secara oral. Hal ini juga dinilai efektif untuk dapat mengurangi angka kunjungan ke rumah sakit serta mencegah komplikasi yang mungkin dapat berakibat kematian (Reid et al., 2024).

Tindakan perawatan nutrisi tidak hanya dapat dilakukan pasca pengobatan, namun juga dapat diberikan sebelum terapi. Pada pasien dengan kanker kerongkongan, dukungan nutrisi selama fase periradioterapi dapat membantu mencegah penurunan berat badan, menjaga kualitas dan fungsi otot rangka, meningkatkan sensitivitas terhadap radiasi, menurunkan toksisitas radiasi dan tingkat penghentian pengobatan, meningkatkan tingkat penyelesaian radiasi, dan meningkatkan hasil kuratif pasien (Wang et al., 2022).

2. Perawat Advokat

Dalam perawatan paliatif, perawat memiliki peran dalam memberikan advokasi bagi pasien dan keluarga untuk memastikan mereka menerima perawatan yang tepat dan dukungan. Perawat bekerja sama dengan tim medis, menangani kebutuhan klien, dan memudahkan

komunikasi antara klien dan penyedia layanan (Reid et al., 2024).

3. Perawat Peneliti

Perawat sebagai pemberi intervensi keperawatan, membutuhkan dasar berupa dasar ilmiah yang didapat dari penelitian baik yang dilaksanakan di layanan klinik ataupun komunitas. Penelitian dapat menggali berbagai hal berkaitan dengan masalah keperawatan yang terjadi. Penggunaan hasil penelitian dapat digunakan dalam bentuk sumber rujukan penentuan standar operasional prosedur keperawatan maupun penentuan kebijakan.

Khususnya, berkaitan dengan masalah nutrisi pada pasien kanker, perawat peneliti dapat menggali hal-hal berkaitan dengan edukasi dan intervensi nutrisi. Penilaian efektifitas, inovasi media yang digunakan, serta variabel yang diukur pada pasien, dapat digali lebih lanjut (Liebermann et al., 2023).

4. Perawat Penyuluh

Perawat sebagai penyuluh, memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai diagnosa penyakit klien, pengobatan yang bisa dijalani, efek samping yang mungkin akan timbul, serta bagaimana perawatan diri yang dapat dilakukan oleh klien di luar rumah sakit (Reid et al., 2024, Dowling et al., 2024). Perawat dapat memberikan edukasi melalui kunjungan rumah sakit, kunjungan rumah, dan konsultasi melalui telepon (Liebermann et al., 2023).

D. Peran Perawat dalam Edukasi Nutrisi Pasien Kanker

Menjalankan fungsi utama perawat sebagai edukator, perawat memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kesehatan bagi pasien. Edukasi yang diberikan dapat berupa edukasi kesehatan umum ataupun edukasi kesehatan yang bersifat khusus seperti masalah nutrisi yang dialami oleh pasien kanker.

Beberapa hal yang dapat dilakukan berkaitan dengan edukasi masalah nutrisi pada pasien kanker adalah;

1. Mengidentifikasi masalah nutrisi sesuai kebutuhan pasien dan keluarga

Pengkajian awal mengenai masalah nutrisi dan kebutuhan pasien dan keluarga adalah pondasi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya di dalam menentukan intervensi.

Penelitian terdahulu meningkatkan pengetahuan mengenai kahexia dan penyebabnya. Kahexia merupakan hal yang sensitif untuk dibicarakan baik kepada pasien dan keluarga. Makan adalah tindakan sosial, dan perubahan yang disebabkan oleh penyakit itu sendiri dan/atau pengobatan (perubahan pola makan) dapat menyebabkan isolasi dan depresi. Dengan pengkajian mengenai kebutuhan serta modifikasi materi edukasi sesuai kebutuhan, keluarga merasa mengalami peningkatan hubungan dengan pasien melalui makan dan makanan yang disediakan serta lebih memahami cara mencegah terjadinya malnutrisi (Buonaccorso et al., 2023).

Penelitian lain melibatkan orang tua dari klien kanker anak untuk mengetahui kebutuhan terkait nutrisi. Para orang tua menyatakan bahwa alasan fisiologis dan diet yang diberikan kepada anak-anak yang dirawat di rumah sakit adalah penyebab utama masalah nutrisi pada anak-anak mereka. Interaksi makanan-obat, interaksi makanan-penyakit, makanan yang harus dimakan atau dihindari oleh anak-anak dengan neutropenia (diet neutripenik), dan frekuensi asupan nutrisi adalah topik utama yang ingin diketahui oleh orang tua (Arpaci et al., 2018).

2. Mengembangkan inovasi metode dan media edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan edukasi

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan metode dan media edukasi nutrisi bagi pasien kanker antara lain adalah usia; tingkat pengetahuan penyakit; dan ketersediaan sumber daya pendukung.

Tingkat pengetahuan mengenai penyakit yang dialami perlu dikaji terlebih dahulu sebelum memberikan edukasi. Klien dengan keadaan yang lebih lanjut memiliki pengetahuan yang baik mengenai pencegahan kanker, namun sayangnya pengetahuan mengenai penanganannya masih terbatas (Etapé, 2018). Hal sebaliknya, pengetahuan pada klien anak yang mengalami kanker juga mungkin terbatas karena terbatasnya paparan informasi mengenai hal tersebut (Tuominen et al., 2023).

Klien lansia memiliki fungsi kognitif yang lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat dengan usia di bawahnya. Hal ini kemudian menyebabkan rendahnya literasi atau pemahaman lansia mengenai penyakit. Lansia seringkali tidak dapat mengenali masalah kesehatan yang terjadi pada tubuhnya, termasuk masalah nutrisi, dikarenakan mereka menganggap sakit adalah hal yang sudah biasa. Penurunan fungsi kognitif juga perlu dipertimbangkan dalam memberikan intervensi berupa edukasi bagi pasien (Estapé, 2018).

Sumber daya pendukung bagi pasien dapat berasal dari keluarga, pengasuh, sebaya, dan juga tenaga kesehatan.

Edukasi sangat penting diberikan kepada pasien dan masyarakat. Beberapa klien lansia lebih menerima informasi yang didapat melalui teman sebayanya dengan pengalaman yang telah dialami oleh temannya terkait penyakit yang sama. Selain pentingnya edukasi bagi pasien dan keluarga, edukasi terhadap tenaga kesehatan lain mengenai pentingnya nutrisi, perlu ditekankan oleh perawat dalam menjalankan kolaborasi (DeSantis et al., 2019, Liebermann et al., 2023).

Beberapa studi terdahulu menunjukkan berbagai macam metode edukasi dapat digunakan untuk mengedukasi masalah nutrisi pada klien kanker.

Sebuah penelitian telah mengembangkan metode edukasi kesehatan dengan memberikan edukasi selama satu jam bagi klien mengenai diet sehat, perubahan diet

pada saat kemoterapi, malnutrisi, dan efek samping yang mungkin timbul karena kanker terhadap nutrisi dan bagaimana cara menanganinya. Efek samping berkaitan nutrisi yang disampaikan adalah masalah kesehatan mulut yang mungkin akan timbul, kesulitan menelan, nyeri, muntah, konstipasi, diare, anoreksia, penurunan nafsu makan dan berat badan, serta perubahan indra perasa. Studi tersebut menilai efektif untuk meningkatkan pengetahuan klien dan mengurangi jumlah kunjungan ke rumah sakit akibat masalah nutrisi karena kanker (Tuominen et al., 2023).

Studi lain mengkaji tentang pengetahuan klien beserta pengasuh dan keluarga, mengenai kaheksia. Metode yang digunakan adalah intervensi yang menggunakan pendekatan psiko-edukasi melalui booklet dengan pemberian edukasi minimal dua sesi. Topik pembahasan antara lain merubah pola makan, alternative pola makan yang dapat dilakukan dan bagaimana keluarga serta pengasuh dapat memberi dukungan, serta menggali kebutuhan tambahan yang diperlukan (Buonaccorso et al., 2023).

Metode lain dapat digunakan dengan memberikan edukasi dan melakukan perawatan mulut serta memonitor kejadian mukositis oral selama 6 minggu. Penelitian tersebut menunjukkan rendahnya kejadian mukositis oral dengan intervensi edukasi yang diberikan mengenai perawatan kebersihan mulut pada pasien

kanker kepala dan leher serta kanker paru (Kara et al., 2023).

Pengembangan terapi dengan mengembangkan metode konsultasi online juga dinilai berpengaruh terhadap status nutrisi pasien. konsultasi keperawatan online mengenai nutrisi dan disfagia untuk pasien kanker dilakukan setiap Kamis sore dan mengevaluasi status gizi setiap pasien dan masalah disfagia menggunakan alat penilaian, dan kemudian, menyediakan e-konseling untuk membantu keterampilan pasien untuk mengatasi kahexia dan gejala terkait (Zhao et al., 2021).

Salah satu studi menunjukkan penggunaan edukasi dan konseling dalam jangka panjang (16 minggu) dengan intervensi bernama CANCER-AIMS yang terdiri dari Conversation (Pembicaraan), Assessment (Pengkajian), Nutrition plan (Perencanaan Nutrisi), Complications (Komplikasi), Evaluation (Evaluasi), dan Reassurance (Penjaminan) atau Removal (Pemusnahan) (CANCER) menjadi Altering Intake and Managing Symptoms (AIMS) atau mengubah makanan dan manajemen gejala. Studi tersebut menunjukkan peningkatan jumlah masukan makanan, rendahnya gejala masalah nutrisi, dan peningkatan status nutrisi (Ren et al., 2024).

Penelitian lain menggunakan booklet dengan pertemuan total sebanyak dua sesi dalam tiga minggu melibatkan pasien dan pengasuh keluarga. Sesi pertama berlangsung selama 30 menit untuk menggali kemampuan klien kanker nasofaring mengenai masalah

nutrisi yang mungkin dihadapi. Pertemuan selanjutnya berlangsung selama 20 menit dilaksanakan di minggu ketiga untuk mengevaluasi praktik yang sudah dilaksanakan selama tiga minggu. Booklet bergambar berisi materi pengenalan gejala masalah nutrisi, masalah nutrisi di mulut dan tenggorokan serta konstipasi. Booklet juga mengandung penjelasan tentang strategi perawatan diri, termasuk penggunaan obat, perawatan mulut, penyesuaian pola makan dan modifikasi gaya hidup (Xiao et al., 2021).

3. Mengevaluasi pemahaman pasien dan keluarga terhadap edukasi

Salah satu cara untuk menilai efektifitas edukasi yang diberikan adalah dengan mengevaluasi pemahaman keluarga dan pasien terhadap edukasi. Penelitian terdahulu mengevaluasi tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi untuk menilai sejauh mana pemahaman pasien mengenai materi yang telah disampaikan oleh perawat menggunakan kuesioner yang dikembangkan sendiri kemudian diuji ahli untuk validitasnya (Tuominen et al., 2023, Buonaccorso et al., 2023).

4. Mengembangkan kebijakan publik yang diperlukan untuk edukasi nutrisi bagi pasien kanker

E. Simpulan

Permasalahan nutrisi utama yang mayoritas terjadi pada pasien kanker antara lain adalah masalah pada mulut

(stomatitis, xerostomia, disfagia), masalah pada perut (nausea, muntah, diare, dan konstipasi). Hal ini diperburuk dengan kemampuan pasien dalam menjaga kesehatan diakibatkan oleh kelemahan fisik yang dialami. Kompleksitas permasalahan kesehatan nutrisi pasien kanker digunakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi yang efektif terkait peran perawat khususnya dalam memberikan edukasi nutrisi bagi pasien kanker. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perawat dalam memberikan edukasi masalah nutrisi untuk pasien kanker adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi masalah nutrisi sesuai kebutuhan pasien dan keluarga; 2) Mengembangkan inovasi metode dan media edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan edukasi; 3) Mengevaluasi pemahaman pasien dan keluarga terhadap edukasi yang telah diberikan, dan 4) Mengembangkan kebijakan publik yang diperlukan untuk edukasi nutrisi bagi pasien kanker.

F. Referensi

- ARPACI, T., TORUNER, E. K. & ALTAY, N. 2018. Assessment of Nutritional Problems in Pediatric Patients with Cancer and the Information Needs of Their Parents: A Parental Perspective. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 5, 231-236.
- BUONACCORSO, L., FUGAZZARO, S., AUTELITANO, C., BERTOCCHI, E., ACCOGLI, M. A., DENTI, M., COSTI, S., MARTUCCI, G., BRAGLIA, L. & BASSI, M. C. 2023. Psycho-educational and rehabilitative intervention to manage cancer cachexia (PRICC) for advanced

- patients and their caregivers: lessons learned from a single-arm feasibility trial. *Cancers*, 15, 2063.
- CUSHEN, S. J., MURPHY, M. & JOHNSTON, K. E. 2025. "What Women Want": Focus group discussions to inform the design of nutrition resources for women impacted by menopause following cancer treatment. *Clinical Nutrition Open Science*.
- DESANTIS, C. E., MILLER, K. D., DALE, W., MOHILE, S. G., COHEN, H. J., LEACH, C. R., GODING SAUER, A., JEMAL, A. & SIEGEL, R. L. 2019. Cancer statistics for adults aged 85 years and older, 2019. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 69, 452-467.
- DOWLING, M., PAPE, E., GEESE, F., VAN HECKE, A., BRYANT-LUKOSIUS, D., CERÓN, M. C., FERNÁNDEZ-ORTEGA, P., MARQUEZ-DOREN, F., WARD, A., SEMPLE, C., KING, T., GLARCHER, M. & DRURY, A. 2024. Advanced Practice Nursing Titles and Roles in Cancer Care: A Scoping Review. *Seminars in Oncology Nursing*, 40, 151627.
- ERICKSON, N., SULOSAARI, V., SULLIVAN, E. S., LAVIANO, A., VAN GINKEL-RES, A., REMIJNSE, W., WESSELING, J., KOEPCKE, U., WEBER, N., HUEBNER, J., MATHIES, V., THEURICH, S. & FEY, T. 2025. Nutrition Care in Cancer: An Overlooked Part of Patient-Centered Care. *Seminars in Oncology Nursing*, 151799.
- ESTAPÉ, T. 2018. Cancer in the Elderly: Challenges and Barriers. *Asia Pac J Oncol Nurs*, 5, 40-42.
- FERLAY, J., COLOMBET, M., SOERJOMATARAM, I., PARKIN, D. M., PIÑEROS, M., ZNAOR, A. & BRAY, F. 2021. Cancer statistics for the year 2020: An overview. *International journal of cancer*, 149, 778-789.

- HOPKINSON, J. B. 2015. Nutritional support of the elderly cancer patient: The role of the nurse. *Nutrition*, 31, 598-602.
- HOPKINSON, J. B. 2023. The role of the nurse in meeting the educational needs for self-care in cachectic cancer patients and their family caregivers: A scoping review. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 10, 100294.
- IBRAHIM, A. M. & FATHI ZAGHAMIR, D. E. 2024. Innovating supportive nutrition assessment for pediatric cancer patients undergoing radio-chemotherapy. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 21, 100811.
- KARA, H., ARIKAN, F., KARTOZ, F. & KORCUM SAHIN, A. F. 2023. A Prospective Study of Nurse-Led Oral Mucositis Management: Impact on Health Outcomes of Patients Receiving Radiotherapy for Head and Neck Cancer and Lung Cancer. *Seminars in Oncology Nursing*, 39, 151440.
- LIEBERMANN, E., SEGO, R., VIEIRA, D., CHENG, Q., XU, B., AROME, M., AZEVEDO, A., GINSBURG, O. & SO, W. K. W. 2023. Roles and activities of nurses in cancer prevention and early detection in low- and middle-income countries: A scoping review. *Asia Pac J Oncol Nurs*, 10, 100242.
- NIH, N. C. I. 2021. *Age and Cancer Risk* [Online]. [Accessed January 11 2025].
- REID, P., PATTERSON, K., MCCULLOCH, E., WALSH, L., MURSHID, A., KINSELLA, W., MOORE, A., SKOURAS, T. & SMITH, P. J. 2024. Nurse-led approach to standardising the management of iron-deficiency anaemia, achieving the 2-week cancer pathway

- targets and reducing hospital admissions: practicalities and learnings from a success story. *Frontline Gastroenterology*, 15, 162-169.
- REN, L., FU, Y., WANG, Z., MA, C., AHN, S. & MENG, Q. 2024. Effectiveness of the CANCER-AIMS intervention on nutritional status and symptom management in patients with gastric cancer following gastrectomy: A randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*, 159, 104873.
- ROGERS, N., WOODHAM, D. & FLETCHER, J. 2023. Nutrition nurse-led outpatient 'hot' clinics are efficient and cost-effective: a retrospective single-centre evaluation. *British Journal of Nursing*, 32, S8-S13.
- RÖHRL, K., GUREN, M. G., SMÅSTUEN, M. C. & RUSTØEN, T. 2019. Symptoms during chemotherapy in colorectal cancer patients. *Supportive Care in Cancer*, 27, 3007-3017.
- SHAROOR, L. A. 2019. Improving oncology nurses' knowledge, self-confidence, and self-efficacy in nutritional assessment and counseling for patients with cancer: A quasi-experimental design. *Nutrition*, 62, 131-134.
- TUOMINEN, L., RITMALA, M., VAHLBERG, T., MÄKELÄ, S., NIKANDER, P. & LEINO-KILPI, H. 2023. The effect of nurse-led empowering education on nutrition impact side effects in patients with colorectal cancer undergoing chemotherapy: A randomised trial. *Patient Education and Counseling*, 115, 107895.
- VAN LIESHOUT, R., LIZE, N., TICK, L. W., VAN DEURSEN, J., DRIESSEN, E., JANSSEN, T., CUSTERS, S., KRANENBURG, S., VAN DER LEE, D., KOENE, H. R., BECKERS, E. A. M., SCHOUTEN, H. C. & BEIJER, S.

2022. Nutrition-related problems, nutritional support practices and barriers to adherence to nutritional guidelines during intensive treatment for acute myeloid leukemia: Patients' and hematology nurses' perspectives and experiences. *Clinical Nutrition ESPEN*, 48, 446-455.
- WANG, P., ZHENG, X., LUO, Z., WANG, Y., GUO, Z. & ZHOU, Y. 2022. Perceptions and experiences of nutritional management needs for patients with esophageal cancer during the peri-radiotherapy period: A qualitative study. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 9, 202-209.
- XIAO, W., CHAN, C. W., XIAO, J., WONG, C. L. & CHOW, K. M. 2021. Development of A Nurse-Led Educational Intervention Program in Managing the Nutrition Impact Symptom Cluster in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma following the Medical Research Council Framework. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 8, 653-661.
- ZHAO, Y., PANG, D. & LU, Y. 2021. The Role of Nurse in the Multidisciplinary Management of Cancer Cachexia. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 8, 487-497.
- ZHENG, D.-D., JIN, T., LI, D., BAO, K.-N. & JIN, R.-H. 2024. Identification of the Core Nutrition Impact Symptoms Cluster in Patients with Lung Cancer During Chemotherapy: A Symptom Network Analysis. *Seminars in Oncology Nursing*, 151794.
- ZUO, F., LI, T., CHEN, Y., WEN, M. & CAO, H. 2024. Knowledge, attitudes, barriers and practices concerning cancer therapy-associated oral mucositis amongst oncology nurses: A mixed methods systematic

review. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*,
11, 100542.

G. Glosarium

KNF: Kanker Nasofaring

CHAPTER 3

PERAWATAN PALIATIF PADA PASIEN KANKER

Christina Yeni Kustanti,
S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D.

A. Pendahuluan

Perawatan paliatif merupakan suatu area perawatan yang mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1992. Perawatan paliatif sering diidentikkan dengan perawatan hospis. Hospis modern pertama didirikan oleh Cicely Saunders, yang dipandang sangat berperan dalam pendirian disiplin dan budaya perawatan paliatif. Saunders memperkenalkan manajemen nyeri dan pengurangan ketidaknyamanan lain yang efektif dan menekankan pentingnya metodologi ilmiah yang ketat dalam pengujian pengobatan, serta martabat, belas kasih, dan rasa hormat yang seharusnya diberikan kepada individu di akhir kehidupannya.

Pada tahun 1918, Cicely Mary Strode Saunders lahir di Barnet, Hertfordshire. Pada usia 10 tahun, dia terdaftar di Roedean School. Kisah hidup Saunders mirip dengan tokoh keperawatan, Florence Nightingale. Keduanya berasal dari keluarga berada dan ditentang untuk menjadi seorang perawat. Pada tahun 1944, Saunders terdaftar sebagai siswa

perawat di St. Thomas' Hospital, menentang nasihat orang tuanya dan meninggalkan jalur pendidikannya setelah pecahnya Perang Dunia II. Dengan berbagai pertimbangan, dia mengambil pendidikan kedokteran, untuk mewujudkan keinginannya untuk mengembangkan perawatan paliatif. Pada akhir tahun 1959, beliau merancang keinginannya untuk mendirikan hospis. Awalnya, dia berniat agar itu menjadi hospis Gereja Inggris; namun, beberapa organisasi pemberi hibah mengharuskan dia untuk membuatnya dapat diakses oleh individu dari semua agama, sehingga dia mengubah rencananya.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Richmond (2005), bahwa pada tahun 1967, St. Christopher's Hospice didirikan di wilayah barat daya London. Hospis ini merupakan pencapaian pribadi dari Saunders, dan saat ini telah dikembangkan juga di berbagai negara di dunia. Saunders menyumbangkan sebagian dari uang pribadinya dan mengumpulkan dana untuk hospis tersebut. Hospis yang didirikan oleh Saunders terdiri dari 54 tempat tidur rawat inap. Hospis ini menyediakan layanan perawatan rumah dan untuk individu yang memerlukan rawat inap. Pada tahun 1967, hospis ini mulai menerima pasien pertama mereka. Hospis tersebut segera memperluas operasinya untuk mencakup penelitian dan mendirikan pusat studi. Pada tahun 1970, *National Health Service* (NHS) bertanggung jawab atas dua pertiga dari biaya operasional, dan dokter-dokter NHS menyelesaikan sebagian dari pelatihan spesialisasi mereka di sana.

Saunders memperkenalkan konsep "nyeri total," yang mencakup perawatan nyeri pasien secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Saunders adalah seorang auditor yang tekun dan mempertahankan pendekatan sistematis terhadap keluhan dari pasien. Seorang pasien yang dipindahkan dari rumah sakit lain ke St. Christopher's menyampaikan perbedaan dengan perawatan sebelumnya yang lebih mengukur bagaimana pasien dapat bertahan terhadap nyerinya tanpa suntikan. Sementara, setelah perawatan hospis dikembangkan, pasien merasa lebih diperhatikan keluhan nyerinya dan merasa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan keluhannya, dan bahwa tenaga kesehatan akan benar-benar memperhatikan keluhannya ini. Pasien merasa lebih nyaman dan tenang.

Setelah itu, hospis yang kemudian dikenal sebagai perawatan paliatif (*palliative care*) mulai berkembang di banyak negara. World Health Organization (WHO) mendefinisikan *palliative care* sebagai "pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien (dewasa dan anak-anak) serta keluarga mereka yang menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa. Perawatan ini mencegah dan meredakan penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang tepat, dan pengobatan nyeri serta masalah lainnya, baik yang bersifat fisik, psikososial, maupun spiritual" (WHO, 2020).

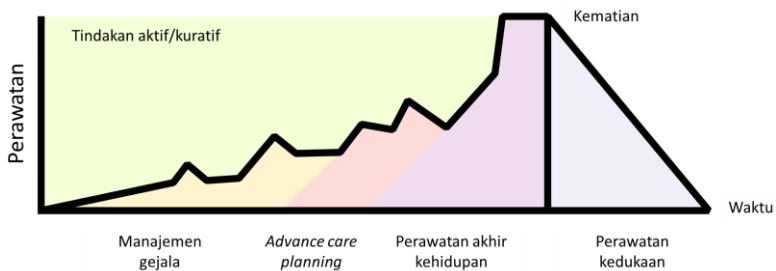
B. Area Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif, perawatan akhir hayat (*end-of-life care*), dan perawatan berduka (*bereavement care*) adalah salah satu area sistem kesehatan yang mungkin kurang populer dibandingkan dengan area pelayanan kesehatan lainnya, yang mempengaruhi semua manusia dan hanya dapat dipahami melalui disiplin ilmu lintas sektor. Kebutuhan global akan pendekatan perawatan ini berkembang pesat di dunia sosial yang menua dan berubah dengan sumber daya perawatan yang terbatas. Berikut ini akan dibahas berbagai definisi dan pendekatan untuk masing-masing area di perawatan paliatif:

1. Perawatan paliatif primer (*primary palliative care*)

Perawatan paliatif didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien (dewasa dan anak-anak) dan keluarga mereka yang menghadapi masalah terkait penyakit yang membatasi kehidupan, biasanya bersifat progresif. Perawatan paliatif primer dapat diberikan sejak seseorang terdiagnosis dengan suatu penyakit yang termasuk dalam penyakit *advanced* (serius dan mengancam jiwa) atau penyakit-penyakit kronis. Contoh diagnosis tersebut adalah kanker, penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ketika beredar diskusi yang menyatakan bahwa perawatan paliatif adalah indikasi bahwa seseorang telah mendekati tahap terminalnya, hal tersebut adalah tidak tepat. Paliatif diberikan dengan tujuan utama mempertahankan,

bahkan meningkatkan kualitas hidup orang-orang dengan penyakit progresif. Jadi sejak awal terdiagnosis, pasien sudah dapat menerima perawatan paliatif, meskipun porsinya akan lebih kecil dibandingkan upaya pengobatan dan perawatan lainnya, dan akan berubah-ubah porsinya sesuai dengan perkembangan penyakit dan kondisi pasien (*illness trajectories*).



Gambar 3.1 Model perawatan paliatif terintegrasi
(*Handbook of Palliative Medicine*)

Gambar menunjukkan bahwa pelayanan paliatif dapat bersinergi dengan tindakan aktif atau kuratif lainnya, dengan proporsi yang dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan penyakit atau dinamika kondisi pasien. Perawatan paliatif menggunakan pendekatan tim yang melibatkan perawat, dokter, apoteker, pekerja sosial, psikolog, konselor spiritual, relawan, dan profesional lainnya yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Anggota tim dan layanan ditentukan oleh kebutuhan dan tujuan pasien. Perawatan paliatif dapat mencakup manajemen gejala dan nyeri,

serta cara-cara lain untuk meredakan penderitaan, baik itu secara mental maupun spiritual. Ini menawarkan sistem dukungan untuk memberikan kenyamanan dan martabat kepada pasien, serta kualitas hidup terbaik bagi mereka dan keluarga mereka, termasuk perawatan berduka bagi orang-orang yang signifikan. Banyak orang dapat memperoleh manfaat dari perawatan paliatif, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang lebih tua yang telah didiagnosis dengan penyakit yang membatasi kehidupan atau diinformasikan oleh profesional medis bahwa kematian dapat diharapkan.

2. Perawatan akhir kehidupan (*end-of-life care*)

Perawatan akhir hayat biasanya didefinisikan sebagai perawatan bagi orang-orang yang kemungkinan besar akan meninggal dalam waktu satu tahun, atau berbagai sumber yang lain menggunakan periode enam bulan. Perawatan ini bertujuan memungkinkan mereka untuk hidup sebaik mungkin hingga akhir hayat mereka, serta meninggal dengan martabat. Bagi beberapa orang dan kondisi kesehatan tertentu, tanda-tanda mendekati akhir hayat dapat terlihat jauh sebelumnya. Namun, pada beberapa kasus, orang mungkin hanya memiliki waktu beberapa bulan atau minggu sebelum akhir hayat tiba. Indikator waktu dibuat oleh dokter sebagai prognosis penyakit pasien dan mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya, mengingat kematian tetap merupakan rahasia dari Sang Pencipta. Mengenali saat seseorang kemungkinan akan meninggal adalah tantangan bagi

para klinisi untuk diprediksi, dan hal ini dapat menambah kesulitan bagi individu dan keluarga dalam mengambil keputusan terkait perawatan di akhir hayat. Untuk itulah saat ini juga dikenal istilah Advance Care Planning dengan menekankan pentingnya perencanaan akhir kehidupan yang dirancang oleh pasien, keluarga, bersama-sama dengan tim kesehatan (Martina et al., 2022).

Akhir kehidupan bisa menjadi pengalaman paling buruk dan tidak menyenangkan bagi seseorang. Hal ini merupakan musibah baik bagi individu, maupun keluarganya. Salah satu hasil utama dari perawatan dalam situasi apa pun seharusnya adalah pengalaman "kematian yang bermartabat" bagi pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Perawat memainkan peran penting dalam merawat pasien, mendukung pasien dan keluarga mereka, serta memberikan perawatan langsung yang berkelanjutan. Namun, apa yang terjadi di akhir kehidupan dan perawatan apa yang seharusnya diberikan masih belum jelas. Konsep "kematian yang bermartabat" sangat kontroversial dan belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai hal ini. Keperawatan didefinisikan sebagai aktivitas membantu, mendukung, dan memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan potensial dan aktual individu atau kelompok. Tujuan dari perawatan akhir hayat (End-of-Life Care/EOLC) adalah membantu pasien menjalani kehidupan secara alami meskipun ada komplikasi yang disebabkan oleh penyakit (Abbaspour and Heydari, 2022).

Pendekatan pengintegrasian perawatan di negara-negara maju dirancang sedemikian rupa sehingga perawatan paliatif diberikan secara global dan sistematis, serta dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Perawatan paliatif adalah kerja tim dan tugas lintas disiplin; perawat juga berperan penting dalam membantu tim perawatan paliatif meningkatkan hasil bagi pasien. Perawatan akhir hayat mencakup elemen-elemen perawatan sosial, psikologis, dan spiritual.

Orang yang mendekati akhir hayat sering mengalami rasa sakit, kelelahan, anoreksia, sesak napas, dan kecemasan. Perawatan paliatif dalam bentuk intervensi medis dan pendekatan rehabilitatif dapat diberikan untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Salah satu yang dilaporkan oleh WHO dalam review mereka adalah "Apa bukti tentang peran seni dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan?" mengutip studi-studi yang menemukan bahwa terapi musik dan seni juga dapat membantu meredakan gejala fisik dan mengurangi rasa sakit, serta mengatur detak jantung dan membantu pernapasan yang terganggu. Partisipasi dalam seni telah dikaitkan dengan tingkat kelelahan (*fatigue*) yang lebih rendah.

3. Perawatan kedukaan (*bereavement care*)

Perawatan duka cita adalah aspek eksplisit dari perawatan paliatif holistik yang mencakup perhatian terhadap mereka yang penting bagi pasien (WHO, 2020). Perawatan duka cita memastikan bahwa

keluarga dan orang-orang terdekat pasien mendapatkan dukungan sejak waktu diagnosis hingga setelah kematian pasien. Dukungan ini dapat berupa informasi, bantuan praktis, dukungan sosial, dan bagi beberapa orang, konseling serta dukungan psikologis.

Perawatan kedukaan dipandang perlu untuk dilaksanakan karena meskipun dianggap sebagai reaksi normal paska kehilangan anggota keluarga, kenyataannya reaksi berduka dapat menjadi berkepanjangan dan terkomplikasi. Kejadian reaksi berduka yang terkomplikasi dialami oleh 9.8% sampai 49% individu yang berduka, tergantung dari penyebab kedukaan itu sendiri (Djelantik et al., 2020, Kustanti et al., 2022, Kustanti et al., 2022, Kustanti et al., 2023, Lundorff et al., 2017). Reaksi berduka yang terkomplikasi, atau disebut sebagai *grief disorder*, dapat menyebabkan berbagai keluhan yang lebih serius, tidak hanya secara mental, tetapi juga secara fisik, bahkan dapat menimbulkan kematian karena sakit atau bunuh diri paska kehilangan. Dukungan kedukaan terbukti dapat mengurangi intensitas duka dan menghindari masalah fisik dan psikologis lanjutan (Kustanti et al., 2021).

C. Perawatan Paliatif untuk Orang dengan Kanker

Pada awalnya, perawatan paliatif hanya dihubungkan dengan perawatan pasien kanker. Selain itu, perawatan paliatif juga sering dianggap hanya untuk pasien di tahap terminal. Ketika seorang pasien kanker dirujuk ke departemen paliatif, muncul anggapan bahwa pasien telah memasuki fase akhir kehidupan. Padahal, perawatan paliatif tidak hanya untuk pasien kanker dan tidak selalu untuk perawatan akhir kehidupan. Oleh karena itu, berbagai bentuk sosialisasi perawatan paliatif dan berbagai areanya perlu dilakukan secara terus-menerus.

Kanker adalah “penyakit akibat proliferasi tak terkendali oleh sel-sel yang mengalami transformasi dan tunduk pada evolusi melalui seleksi alam” (Brown et al., 2023). Kanker pertama kali dikenali sebagai massa jaringan yang tumbuh, yaitu tumor. Tumor ini dapat diamati bentuknya, seberapa cepat pertumbuhannya, dan seringkali terlihat seperti “menggerogoti” tubuh. Tumor-tumor tersebut, pada beberapa kasus, tampak menyebar ke bagian tubuh lainnya dan diakui sebagai kondisi yang fatal.

Untuk dapat memberikan pencegahan dan penanganan yang adekuat, berbagai penelitian dilakukan untuk dapat mengidentifikasi berbagai keluhan akibat kanker. Suatu penelitian dilakukan oleh Scheel and Holtedahl (2015) untuk mereview berbagai keluhan yang dialami oleh pasien kanker. Gejala yang dianggap sebagai *Warning Signs of Cancer* (WSC) khas untuk beberapa jenis kanker umum tidak selalu sering terjadi. Misalnya, “masalah pencernaan”

tercatat pada 25 dari 68 kasus kanker organ pencernaan, dan "perdarahan" ditemukan pada delapan kasus. Dari 35 pasien kanker payudara, sepuluh di antaranya memiliki "benjolan". Dari 23 pasien kanker paru-paru, delapan mengalami "batuk". Pada 12 kasus melanoma ganas, "tahi lalat" tercatat pada tujuh kasus, "benjolan" pada dua kasus, dan "lesi kulit" pada dua kasus. Satu kasus terakhir tidak memiliki informasi tentang bagaimana diagnosis dilakukan. Variasi persepsi gejala seperti ini juga ditemukan pada 12 kasus karsinoma sel skuamosa pada kulit, meskipun "lesi kulit" tercatat pada setengah dari kasus tersebut.

Temuan klinis dicatat pada 41 pasien (16%), di mana 16 pasien (39%) tidak memiliki catatan gejala sebelumnya, dan temuan ini bervariasi secara signifikan. Pemeriksaan visual dan palpasi, termasuk palpasi rektal, sering memberikan petunjuk untuk diagnosis. Tes tambahan memberikan informasi pada 59 kasus (22%); di antaranya, 25 kasus (42%) tidak memiliki catatan gejala atau tanda. Di antara sinyal berbasis tes yang dicatat oleh dokter umum, anemia adalah yang paling sering ditemukan, terjadi pada 15 pasien. Dari delapan pasien dengan anemia dan kanker kolorektal, hanya satu pasien yang juga memiliki catatan "perdarahan". Dari enam pasien dengan anemia dan kanker lainnya, dua juga memiliki "perdarahan". Dibandingkan dengan 25 pasien secara keseluruhan yang memiliki catatan "perdarahan" baik pada konsultasi awal maupun sebelum diagnosis, anemia lebih dari separuhnya sering muncul sebagai sinyal independen kanker. Darah samar dalam tinja dicatat hanya

pada tiga kasus kanker kolorektal, satu kasus kanker lambung, dan satu kasus kanker yang telah menyebar secara umum (Scheel and Holtedahl, 2015).

Selain keluhan karena kanker itu sendiri, keluhan yang dialami oleh pasien juga berasal dari berbagai tindakan pemeriksaan dan penanganan untuk kanker. Sebagai contoh, sebuah uji klinis melaporkan frekuensi diare (semua tingkatan) sebesar 34% dan 45% pada pasien yang menerima kemoterapi berbasis fluorourasil-/oksaliplatin-/leukovorin atau kapesitabin-/oksaliplatin selama tiga bulan dan enam bulan, masing-masing. Sebuah studi observasional tentang efek samping kemoterapi yang dilakukan dalam praktik klinis menunjukkan bahwa frekuensi diare (semua tingkatan) pada kanker kolorektal mencapai 75% (107 dari 142 kasus) (Katta et al., 2023). Dalam uji klinis, efek samping kemoterapi sering dilaporkan oleh klinisi, yang mungkin meremehkan insiden dan tingkat keparahan efek samping dibandingkan dengan laporan pasien.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh WHO, perawatan paliatif adalah pengobatan yang bertujuan untuk mengurangi gejala dan penderitaan yang terkait dengan kanker dan penyakit-penyakit serius lainnya, bukan untuk menyembuhkan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Perawatan paliatif bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi individu. Perawatan ini sangat dibutuhkan di daerah dengan persentase pasien kanker stadium lanjut yang signifikan, di mana kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Perawatan paliatif dapat

mengurangi masalah fisik, emosional, dan spiritual pada hampir 90% orang dengan penyakit terminal. Inisiatif kesehatan masyarakat yang efisien, termasuk perawatan berbasis komunitas dan rumah, sangat penting untuk memberikan pengobatan nyeri dan perawatan paliatif bagi pasien dan keluarga mereka. Peningkatan ketersediaan analgetik sangat dianjurkan untuk mengelola nyeri kanker sedang hingga berat, yang dialami oleh hampir 80% individu dengan kanker stadium akhir.

Mempertimbangkan bahwa pasien kanker dapat mengalami berbagai ketidaknyamanan, baik dari penyakit kanker itu sendiri maupun dari efek samping pengobatan atau tindakan lain, maka perawatan paliatif diperlukan untuk mengoptimalkan kualitas hidup orang dengan kanker. Selama lima dekade terakhir, para klinisi, peneliti, dan advokat perawatan paliatif telah belajar dari dan bersama mereka yang hidup dengan kanker untuk menempatkan diri mereka sebagai mitra penting bagi para klinisi onkologi dalam menangani penderitaan ini. Seperti halnya inovasi lainnya, dan berdasarkan bukti manfaatnya, muncul pertanyaan tentang bagaimana dan kapan mengintegrasikan perawatan paliatif ke dalam struktur dan proses perawatan yang sudah ada (Sanders et al., 2024).

Rekomendasi ASCO (*the American Society of Clinical Oncology*) berhubungan dengan perawatan paliatif pada pasien kanker adalah sebagai berikut (Sanders et al., 2024):

1. Perawatan paliatif dini

Studi menunjukkan bahwa rujukan dini ke perawatan paliatif khusus bagi pasien dengan kanker stadium lanjut meningkatkan kualitas hidup (QOL), suasana hati, serta kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendiskusikan atau mendokumentasikan preferensi akhir hayat. Hal ini didukung oleh beberapa RCT (*Randomized Controlled Trials*) yang ketat yang dilakukan sebelum tahun 2016. Pedoman Praktik Klinis ASCO 2016, yang didasarkan pada uji coba ini, menemukan bahwa keterlibatan tepat waktu dalam perawatan paliatif khusus meningkatkan QOL, suasana hati, kontrol gejala, dan kepuasan terhadap perawatan dibandingkan dengan perawatan onkologi standar.

Klinisi onkologi adalah mitra penting dalam mengelola kebutuhan perawatan paliatif primer pasien. Namun, studi tentang perawatan paliatif primer yang ditemukan dalam tinjauan sistematis tidak menunjukkan peningkatan dalam hasil utama mereka, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Rujukan perawatan paliatif secara rutin mungkin lebih disarankan saat diagnosis untuk kanker dengan prognosis buruk daripada pada pasien dengan perjalanan penyakit yang lebih panjang atau berpotensi sembuh.

Semua uji coba yang mengevaluasi peserta dengan tumor padat melibatkan pasien rawat jalan, dan beberapa pihak telah mengusulkan model perawatan paliatif presisi

untuk mendorong distribusi keahlian dan sumber daya yang lebih terarah.

2. Perawatan multidisiplinari

Perawatan paliatif khusus untuk pasien kanker perlu melibatkan tim lintas-departemen yang terdiri dari dokter spesialis, penyedia praktik lanjutan, perawat, psikolog, spesialis rehabilitasi, penyedia perawatan spiritual, pekerja kesehatan komunitas, dan navigator pasien. Tim dapat menggunakan teknologi berbasis web dan tatap muka pada berbagai tahap kanker di komunitas dan fasilitas rumah sakit. Perawatan paliatif bersifat interdisipliner, namun sumber daya untuk dokter onkologi dan terapis dapat bervariasi tergantung pada konteksnya.

Asesmen utama biasanya melibatkan dokter paliatif, penyedia praktik lanjutan, atau perawat. Beberapa tim dalam uji coba ini juga termasuk pekerja sosial, pendeta, psikolog, penyedia perawatan spiritual, pekerja kesehatan komunitas, navigator pasien, dan profesional rehabilitasi dalam fisioterapi, terapi okupasi, atau kedokteran rehabilitasi.

Sebagian besar studi yang melibatkan mengevaluasi pasien dengan kanker stadium lanjut, meskipun satu studi melibatkan pasien kanker paru-paru yang baru didiagnosis, serta studi lainnya yang memfokuskan pada model perawatan terintegrasi dan kombinasi rujukan serta perawatan terintegrasi. Dalam semua uji coba, peneliti menggunakan penilaian standar untuk gejala, spiritualitas, dan faktor psikososial, serta mendiskusikan prognosis dan

pilihan pengobatan untuk mengevaluasi kesadaran prognostik dan memulai pembicaraan tentang perawatan paliatif.

Cara paling praktis untuk memastikan pasien mendapat manfaat dari perawatan paliatif adalah dengan melibatkan tim profesional lintas-disiplin sejak awal dalam perjalanan kanker, menurut temuan studi.

3. Bentuk intervensi paliatif yang dapat diberikan

Hanya beberapa penelitian mengenai bagaimana mendukung caregiver pasien kanker stadium lanjut, terutama di setting dengan sumber daya terbatas. Studi yang terlibat bervariasi dalam hal penyedia perawatan paliatif (perawat atau navigator non-profesional), media (telepon, aplikasi, atau tatap muka), serta tujuan akhir (depresi, kepuasan, QOL). Para peneliti mengungkapkan beberapa metode yang dapat digunakan oleh penyedia layanan kesehatan lintas-disiplin untuk menjangkau pasien, namun variasi ini melemahkan saran mereka.

Perawatan paliatif yang dini dapat mengurangi depresi, stres, beban caregiver, serta gangguan psikologis pada caregiver pasien kanker lanjut dan meningkatkan QOL. Para peneliti menggambarkan pendekatan yang mendukung caregiver. Caregiver mendapatkan manfaat dari intervensi tunggal atau multmodal berdasarkan kebutuhan, lokasi, sumber daya, kenyamanan, dan teknologi mereka. Isi intervensi dapat mencakup psikoedukasi dan rejimen perawatan diri. Dalam tiga hingga empat sesi, intervensi ini layak dan berlangsung

selama 6-12 bulan, memberikan caregiver manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

Studi sebelum pandemi COVID-19 (SARS-CoV-2) menyediakan sebagian besar bukti ilmiah. Rekomendasi sebelumnya menyarankan intervensi telepon untuk komunitas pedesaan dan yang kurang terlayani. Dengan perluasan telehealth dan telemedis terkait pandemi, lebih banyak orang dapat mengakses dan merasa nyaman dengan perawatan virtual. Telehealth, dukungan berbasis aplikasi, dan perawatan virtual yang lebih dapat diakses dan akrab bagi banyak orang dapat meningkatkan akses layanan dukungan bagi populasi yang sebelumnya kurang terlayani yang mungkin kesulitan menghadiri sesi dukungan langsung di fasilitas layanan kesehatan fisik. Akses internet, data, dan smartphone masih terbatas bagi banyak pasien dan caregiver. Oleh karena itu, dukungan telepon tetap penting dalam komunikasi.

4. Target subjek perawatan paliatif

Manajemen kanker komprehensif membutuhkan perawatan paliatif yang tepat waktu. Pasien kanker dengan stadium lanjut lebih sering mengalami gejala yang lebih berat dan memiliki masa hidup yang lebih pendek. Ketika obat-obatan kuratif dan paliatif justru lebih berisiko daripada bermanfaat, kebanyakan dokter kanker lebih memilih perawatan paliatif. Menurut para peneliti, pasien yang dirujuk ke perawatan paliatif khusus setelah pengobatan kanker terarah selesai, mungkin tidak sepenuhnya mendapatkan manfaatnya.

Berdasarkan data, pedoman 2016 menyarankan rujukan ke perawatan paliatif ahli dalam waktu 8 minggu sejak diagnosis kanker lanjut. Setelah meninjau penelitian yang sama dan kesulitan tenaga kerja, Panel ahli menyarankan untuk mengubah rekomendasi menjadi perawatan yang lebih dini. Panel juga mengakui kesulitan dalam interpretasi kata "dini" dalam rujukan perawatan paliatif. Studi intervensi mendefinisikan "dini" sebagai 8-12 minggu setelah diagnosis.

Rujukan perawatan paliatif membuat khawatir pasien dan dokter onkologi, meskipun ada bukti sebaliknya. Meskipun bukti menunjukkan sebaliknya, dokter onkologi mungkin khawatir pasien akan mengartikan rujukan perawatan paliatif sebagai tanda keputusan. Tidak ada standar waktu yang ditetapkan untuk merujuk pasien kanker lanjut ke perawatan paliatif. Panel ahli menyarankan bahwa "dini" seharusnya merujuk pada kebutuhan perawatan paliatif daripada menunggu hingga pengobatan antineoplastik berhenti dalam praktik saat ini. Dini juga mengacu pada perawatan paliatif rawat jalan. Praktisi onkologi dan institusi kesehatan harus melatih semua dokter onkologi dalam perawatan paliatif primer dan kapan harus merujuk ke perawatan spesialis. Dokter onkologi harus memperkenalkan perawatan paliatif sejak awal dalam perjalanan penyakit untuk mengurangi persepsi yang buruk dan usang terkait rujukan perawatan paliatif spesialis. Strategi yang berpusat pada pasien ini menjamin terapi paliatif ahli

melengkapi pengobatan kanker sejak diagnosis. Tanpa evaluasi semacam itu, dokter onkologi seharusnya merujuk pasien dengan gejala yang persisten dan mengganggu (seperti nyeri, mual, atau sesak napas, rawat inap berulang, atau kunjungan ke ruang gawat-darurat akibat komplikasi kanker, atau penurunan fungsi) ke perawatan paliatif spesialis.

5. Strategi khusus untuk pasien kanker hematologi

Malignansi hematologi dan terapi intensif yang menyertainya menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang signifikan. Kemajuan dalam pengobatan kanker telah membantu lebih banyak pasien bertahan hidup, sembuh, atau hidup dengan kanker. Terapi-terapi baru dapat mengurangi morbiditas dan meningkatkan kelangsungan hidup untuk banyak malignansi hematopoietik. Namun, setiap terapi ini melibatkan efek samping yang serius. Malignansi hematologi dikaitkan dengan tingkat rawat inap yang lebih tinggi, lebih banyak kunjungan ICU, lebih banyak kematian di rumah sakit, lebih sedikit rujukan ke hospice, dan masa tinggal di hospis yang lebih singkat dibandingkan tumor padat. Oleh karena itu, pasien dengan gejala yang tidak terkontrol, kebutuhan psikososial, atau masalah QOL, terlepas dari prognosisnya, harus mendapatkan perawatan paliatif dari diagnosis hingga masa hidup setelah kanker.

Namun, organisasi layanan kesehatan jarang mengintegrasikan perawatan paliatif spesialis dalam

penanganan malignansi hematologi. Beberapa faktor berkontribusi pada fenomena ini, termasuk salah persepsi bahwa perawatan paliatif adalah perawatan akhir hayat, kurangnya transisi yang jelas antara tahap kuratif dan paliatif akibat ketidakpastian prognosis, serta kebijakan yang membatasi perawatan simultan. Banyak praktisi perawatan paliatif menghadapi kekhawatiran bahwa konsultasi mereka dapat menyebabkan penghentian pengobatan penyelamat kehidupan secara prematur.

Bukti perawatan paliatif untuk populasi ini sebelumnya tidak tersedia dalam pembaruan pedoman sebelumnya. Studi menyatakan bahwa integrasi perawatan paliatif dalam pengobatan pasien rawat inap dengan malignansi hematologi layak, tetapi bukti terbatas pada pasien AML dan HSCT. Satu RCT menemukan bahwa perawatan paliatif spesialis meningkatkan QOL dibandingkan dengan perawatan rutin pada pasien AML yang menerima kemoterapi intensif. Manfaat ini bertahan hingga enam bulan dan memperbaiki depresi, kecemasan, dan PTSD. Studi multisitus tidak menemukan perubahan dalam beban gejala atau perawatan akhir hayat, tetapi penulis merekomendasikan bahwa organisasi layanan kesehatan memberikan perawatan paliatif kepada pasien AML yang dirawat inap jika tersedia.

RCT lainnya menemukan bahwa konsultasi perawatan paliatif spesialis pada pasien HSCT untuk malignansi hematologi meningkatkan QOL setelah dua minggu. Studi ini menemukan perbaikan pada suasana

hati, beban gejala, dan hasil psikologis. Caregiver pasien dalam kelompok intervensi mengalami peningkatan gejala depresi, tetapi signifikansinya belum diketahui. Secara keseluruhan, terapi perawatan paliatif melebihi risiko yang ada; penelitian lebih lanjut diperlukan.

Panel ahli memahami bahwa rekomendasi untuk semua malignansi hematologi melampaui temuan ini. Pilihan ini mengakui bahwa kelompok pasien ini menderita dengan sangat, penelitian di bidang ini terbatas, dan keahlian klinis Panel menunjukkan potensi manfaat bagi pasien yang lebih luas daripada dua uji coba tersebut.

6. Rekomendasi untuk pasien yang berpartisipasi dalam penelitian

Pasien dalam uji klinis fase I kanker memiliki beberapa gejala terkait dengan keganasannya dan terapi sebelumnya serta menghadapi ketidakpastian tentang masa depan dan pengobatan uji klinis. Kelompok ini juga hidup rata-rata selama enam bulan setelah uji klinis. Partisipasi dalam uji klinis dapat memperburuk masalah kesehatan fisik dan mental. Topik ini memiliki sedikit penelitian; hanya dua studi yang termasuk. Studi-studi tersebut memiliki sedikit hasil yang signifikan secara statistik, tetapi panel ahli memberikan rekomendasi konsensus berdasarkan bukti perawatan paliatif dalam populasi lain dengan kanker lanjut, beban dan kerentanan yang lebih tinggi pada populasi ini, serta kurangnya perhatian pada kelompok ini.

Panel ahli mengakui bahwa pasien dalam uji klinis fase I kanker mungkin memiliki gejala spesifik dan kebutuhan dukungan serta perawatan paliatif. Peserta uji klinis fase I adalah kelompok tertentu dari pasien kanker yang independen secara fungsional, memiliki penyakit lanjut, dan telah menjalani banyak lini pengobatan. Setelah uji klinis, sebagian besar individu memiliki kelangsungan hidup median 5,7-10,7 bulan dan membutuhkan perawatan paliatif. Perawatan paliatif mungkin berlangsung lebih lama akibat temuan baru bahwa obat-obatan baru telah meningkatkan kelangsungan hidup dalam uji klinis.

Peserta uji klinis fase I kanker mungkin menghadapi ketidakpastian tentang masa depan dan banyak gejala terkait penyakit dan pengobatan. Peserta mungkin mengalami kelelahan, gangguan tidur, mual, penurunan nafsu makan, kecemasan, ketidaknyamanan, dan perubahan gastrointestinal. Pasien melaporkan banyak gejala, termasuk kembung, sembelit, buang air kecil yang sering, mulut kering, sesak napas, kecemasan, depresi, dan masalah ingatan serta konsentrasi, yang memengaruhi hampir 40% pasien yang menilai gejala tersebut sebagai parah atau sangat parah. Persyaratan uji klinis dapat memperburuk masalah fisik dan mental. Peserta sering melakukan perjalanan ke lokasi uji klinis, membuat kunjungan klinik yang panjang, dan merasa cemas tentang efek samping serta manfaat dari obat investigasi. Intervensi perawatan paliatif perlu dirancang,

disesuaikan, dan diuji karena sedikit penelitian yang berfokus pada kebutuhan dukungan perawatan peserta yang meningkat.

Para ilmuwan juga menemukan bahwa sedikit peserta uji klinis fase I yang menyelesaikan perencanaan perawatan lanjutan atau menerima perawatan paliatif atau perawatan akhir hayat. Meski memiliki kelangsungan hidup median 10,1 bulan dari pendaftaran, hanya 39% pasien uji klinis fase I yang memiliki pernyataan kehendak, 35% yang memiliki proxy perawatan kesehatan, dan 37% yang mendaftar di layanan hospice. Studi lain menemukan bahwa 47% memiliki konsultasi perawatan paliatif dan 53% memiliki pembicaraan tujuan perawatan. Peserta uji klinis fase I adalah kelompok yang rentan, kurang terlayani, dan memiliki penyakit yang parah, harapan hidup yang rendah, serta penelitian yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan klinis mereka. Perawatan bagi peserta uji klinis fase I sangat penting dan esensial. Partisipasi dalam uji klinis fase I membutuhkan penelitian berkelanjutan untuk mengevaluasi, menangani, dan mengelola kebutuhan perawatan klinis unik mereka serta meningkatkan QOL. Integrasi perawatan paliatif dalam uji klinis fase I dapat meningkatkan partisipasi dan retensi. Solusi yang berhasil untuk kebutuhan dukungan perawatan individu-individu ini membutuhkan perhatian berkelanjutan.

D. Simpulan

Secara keseluruhan, integrasi perawatan paliatif dalam pengelolaan kanker -terutama untuk pasien dengan kanker hematologik lanjut dan mereka yang berpartisipasi dalam uji klinis fase I - adalah penting untuk meningkatkan kualitas hidup (QOL), pengurangan penderitaan, dan kesejahteraan psikologis. Perawatan paliatif awal, idealnya dalam 8-12 minggu setelah diagnosis, telah menunjukkan manfaat yang jelas, termasuk kontrol gejala yang lebih baik, peningkatan suasana hati, dan kepuasan dengan perawatan. Namun, populasi tertentu, seperti pasien dengan kanker hematologik dan peserta uji klinis fase I, menghadapi tantangan unik yang memerlukan pendekatan perawatan paliatif yang sesuai.

Meskipun kemajuan dalam model perawatan telah meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap intervensi paliatif, beberapa hambatan tetap ada, seperti salah paham bahwa perawatan paliatif sama dengan perawatan akhir hayat, variabilitas ketersediaan sumber daya, dan kekhawatiran tentang dampak perawatan paliatif pada pengobatan kuratif. Untuk pasien dengan kanker hematologik, integrasi perawatan paliatif sejak diagnosis, terutama di fasilitas rumah sakit, menunjukkan potensi tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi aplikasinya secara lebih luas dan hasil yang dicapai.

Pasien sebagai partisipan dalam uji klinis fase I, yang menghadapi beban gejala signifikan dan harapan hidup yang terbatas, memerlukan intervensi perawatan paliatif yang spesifik. Pasien-pasien ini seringkali tetap kurang terlayani,

dengan keterlibatan yang terbatas dalam perencanaan perawatan lanjutan dan diskusi tujuan perawatan. Mengembangkan layanan perawatan paliatif untuk populasi ini dapat meningkatkan QOL, manajemen gejala, dan dukungan bagi *caregiver*, sambil memperkuat partisipasi dan retensi dalam uji klinis.

Kesimpulannya, mengatasi kebutuhan perawatan paliatif dari populasi orang dengan kanker memerlukan penelitian berkelanjutan, pengembangan intervensi yang disesuaikan, dan peningkatan kesadaran klinisi untuk memastikan perawatan yang tepat waktu, efektif, dan komprehensif sepanjang perjalanan kanker.

E. Referensi

- Abbaspour, H., Heydari, A., 2022. Concept Analysis of End-of-Life Care. *J Caring Sci* 11 (3), 172-177.
- Brown, J.S., Amend, S.R., Austin, R.H., Gatenby, R.A., Hammarlund, E.U., Pienta, K.J., 2023. Updating the Definition of Cancer. *Mol Cancer Res* 21 (11), 1142-1147.
- Djelantik, A., Smid, G.E., Mroz, A., Kleber, R.J., Boelen, P.A., 2020. The prevalence of prolonged grief disorder in bereaved individuals following unnatural losses: Systematic review and meta regression analysis. *J Affect Disord* 265, 146-156.
- Katta, B., Vijayakumar, C., Dutta, S., Dubashi, B., Nelamangala Ramakrishnaiah, V.P., 2023. The Incidence and Severity of Patient-Reported Side Effects of Chemotherapy in Routine Clinical Care: A

- Prospective Observational Study. *Cureus* 15 (4), e38301.
- Kustanti, C.Y., Chu, H., Kang, X.L., Huang, T.-W., Jen, H.-J., Liu, D., Shen Hsiao, S.-T., Chou, K.-R., 2022. Prevalence of grief disorders in bereaved families of cancer patients: A meta-analysis. *Palliative medicine* 36 (2), 305-318.
- Kustanti, C.Y., Chu, H., Kang, X.L., Pien, L.C., Chen, R., Tsai, H.T., Chou, K.R., 2022. Anticipatory grief prevalence among caregivers of persons with a life-threatening illness: A meta-analysis. *BMJ supportive & palliative care*.
- Kustanti, C.Y., Fang, H.F., Linda Kang, X., Chiou, J.F., Wu, S.C., Yunitri, N., Chu, H., Chou, K.R., 2021. The Effectiveness of Bereavement Support for Adult Family Caregivers in Palliative Care: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Nursing Scholarship* 53 (2), 208-217.
- Kustanti, C.Y., Jen, H.J., Chu, H., Liu, D., Chen, R., Lin, H.C., Chang, C.Y., Pien, L.C., Chiang, K.J., Chou, K.R., 2023. Prevalence of grief symptoms and disorders in the time of COVID-19 pandemic: A meta-analysis. *Int J Ment Health Nurs* 32 (3), 904-916.
- Lundorff, M., Holmgren, H., Zachariae, R., Farver-Vestergaard, I., O'Connor, M., 2017. Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord* 212, 138-149.
- Martina, D., Kustanti, C.Y., Dewantari, R., Sutandyo, N., Putranto, R., Shatri, H., Effendy, C., van der Heide, A., van der Rijt, C.C.D., Rietjens, J.A.C., 2022. Advance care planning for patients with cancer and family

- caregivers in Indonesia: a qualitative study. *BMC Palliat Care* 21 (1), 204.
- Richmond, C., 2005. Dame Cicely Saunders. *Bmj* 331 (7510), 238.
- Sanders, J.J., Temin, S., Ghoshal, A., Alesi, E.R., Ali, Z.V., Chauhan, C., Cleary, J.F., Epstein, A.S., Firn, J.I., Jones, J.A., Litzow, M.R., Lundquist, D., Mardones, M.A., Nipp, R.D., Rabow, M.W., Rosa, W.E., Zimmermann, C., Ferrell, B.R., 2024. Palliative Care for Patients With Cancer: ASCO Guideline Update. *Journal of Clinical Oncology* 42 (19), 2336-2357.
- Scheel, B.I., Holstedahl, K., 2015. Symptoms, signs, and tests: The general practitioner's comprehensive approach towards a cancer diagnosis. *Scand J Prim Health Care* 33 (3), 170-177.
- WHO, 2020. Palliative care.

F. Glosarium

AML = Acute Myeloid Leukemia.

Bereavement care = perawatan atau pendampingan masa berduka pada individu yang kehilangan seseorang.

End-of-life care = perawatan akhir kehidupan atau 6-12 bulan sebelum perkiraan kematian karena penyakit tertentu.

Fatigue = kelelahan yang berlebihan, bahkan tidak teratasi dengan istirahat.

Hibah = sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lainnya kepada individu atau organisasi untuk tujuan tertentu.

Hospis = perawatan khusus yang memberikan kenyamanan fisik serta dukungan emosional, sosial, dan spiritual bagi orang-orang yang mendekati akhir hayat.

HSCT = *Hematopoietic Stem Cell Transplantation*.

Illness trajectories = perjalanan penyakit.

Karsinoma = keganasan.

Lesi = area jaringan abnormal atau rusak yang disebabkan oleh cedera, infeksi, atau penyakit.

Malignansi = keganasan.

Palpasi = pemeriksaan fisik dengan cara perabaan.

Penyakit progresif = sebuah penyakit atau gangguan fisik yang umumnya memiliki perjalanan yang memburuk, berkembang, atau menyebar.

Proliferasi = pertumbuhan sel.

PTSD = *Posttraumatic Stress Disorder*.

PROFIL PENULIS



Ns. Nunung Nursasih, M.Kep., Sp.Kep.MB., Lahir di Jakarta, 09 Mei 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan , dan Profesi Ners, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah

Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2021, Program studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali di Ruang ICCU RS Husada tahun 1992 sd tahun 2018. Tahun 2014 sd 2017 merangkap sebagai ketua sub komite kredensial. Kemudian sebagai kepala divisi keperawatan pada tahun 2018 sd tahun 2022, sebagai Ketua Komite Keperawatan tahun 2022 sd tahun 2023, tahun 2023 sampai dengan saat ini di bagian HRD . Penulis pengajar di beberapa STIKES dan Universitas, sebagai dosen praktisi kampus merdeka, mengampu mata kuliah Keperawatan Kritis, Keperawatan Paliative, Manajemen Keperawatan, Keperawatan persepsi sensori, Keperawatan Kardiovaskular. Penulis aktif dalam organisasi organisasi keperawatan, Organisasi sosial, penulis buku, pembicara seminar dan workshop, serta peneliti. e-mail:nunungnursasih71@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Nur Fithriyanti Imamah, MBA., Ph.D.,

Lahir di Balikpapan, 18 April 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Central

Taichung University of Science and Technology dan lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai Dosen Pengajar di Program Studi S1 Keperawatan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mengampu mata kuliah Keperawatan Paliatif dan Menjelang Ajal, Falsafah dan Teori Keperawatan, dan Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan menulis beberapa artikel jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nfi573@umkt.ac.id

Motto: "Long Life Learner"

PROFIL PENULIS



Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D., Lahir di Yogyakarta, 29 Januari 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akademi Keperawatan Bethesda Yakkum Yogyakarta pada 1999. S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Charles Darwin University dan Flinders University, Australia di tahun 2010 dan 2013. Study S3 diselesaikan pada 2023 di Taipei Medical University, Taiwan. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta sejak tahun 2003. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi artikel, pengelola jurnal, narasumber seminar, penulis buku, serta *founder* untuk BerCa.my.id, sebuah *website* untuk dukungan *bereavement* secara virtual. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yeni@stikesbethesda.ac.id

Buku "Bunga Rampai: Pendekatan Paliatif dan Nutrisi dalam Perawatan Kanker" menyajikan kumpulan pembahasan penting mengenai aspek keperawatan pada pasien kanker, dengan penekanan khusus pada pendekatan paliatif dan nutrisi. Disusun secara sistematis, buku ini mengajak pembaca memahami peran strategis perawat dalam mendampingi perjalanan pasien kanker — mulai dari tahap diagnosis hingga fase perawatan akhir hayat.

Bagian pertama membahas tentang Definisi dan Prinsip Keperawatan Onkologi, memperkenalkan konsep dasar keperawatan dalam konteks onkologi yang berfokus pada pendekatan holistik, berbasis bukti, dan berpusat pada pasien.

Bagian kedua mengulas Peran Perawat dalam Edukasi Nutrisi untuk Pasien Kanker, menekankan pentingnya asupan gizi dalam menunjang kekuatan fisik dan kualitas hidup pasien, serta teknik edukasi efektif yang dapat diterapkan perawat di berbagai setting layanan kesehatan.

Bagian terakhir mengupas tuntas Perawatan Paliatif pada Pasien Kanker, menggambarkan bagaimana pendekatan paliatif tidak hanya mengelola gejala fisik, tetapi juga memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial pasien, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup mereka.

Buku "Bunga Rampai: Pendekatan Paliatif dan Nutrisi dalam Perawatan Kanker" menyajikan kumpulan pembahasan penting mengenai aspek keperawatan pada pasien kanker, dengan penekanan khusus pada pendekatan paliatif dan nutrisi.

Disusun secara sistematis, buku ini mengajak pembaca memahami peran strategis perawat dalam mendampingi perjalanan pasien kanker mulai dari tahap diagnosis hingga fase perawatan akhir hayat.

Bagian pertama membahas tentang Definisi dan Prinsip Keperawatan Onkologi, memperkenalkan konsep dasar keperawatan dalam konteks onkologi yang berfokus pada pendekatan holistik, berbasis bukti, dan berpusat pada pasien.

Bagian kedua mengulas Peran Perawat dalam Edukasi Nutrisi untuk Pasien Kanker, menekankan pentingnya asupan gizi dalam menunjang kekuatan fisik dan kualitas hidup pasien, serta teknik edukasi efektif yang dapat diterapkan perawat di berbagai setting layanan kesehatan.

Bagian terakhir mengupas tuntas Perawatan Paliatif pada Pasien Kanker, menggambarkan bagaimana pendekatan paliatif tidak hanya mengelola gejala fisik, tetapi juga memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial pasien, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

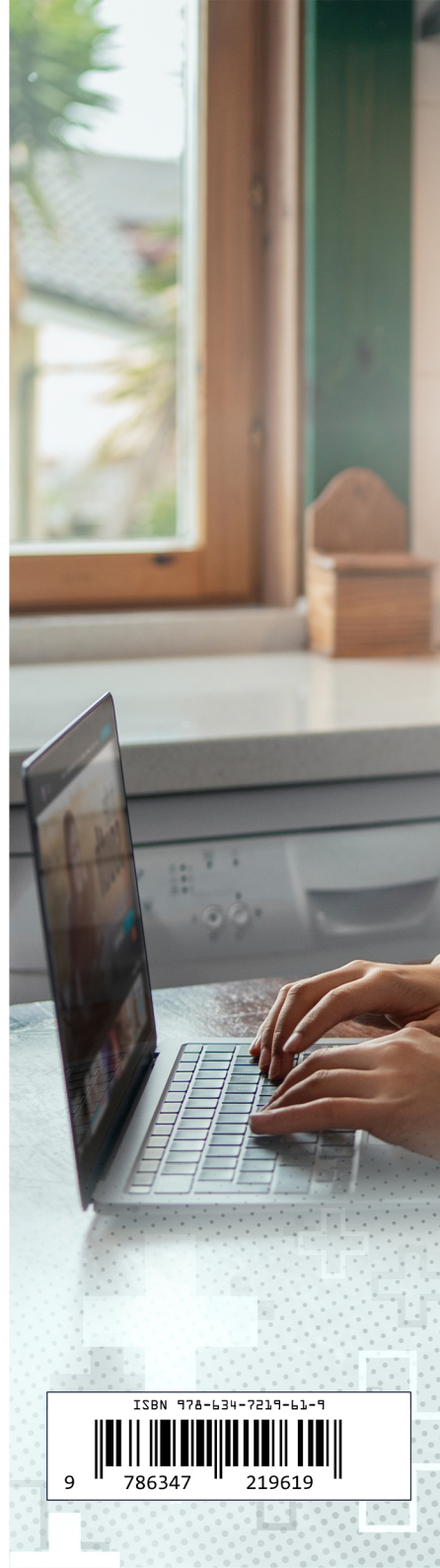
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-61-9



9

786347

219619